



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

KEPERAWATAN KELUARGA DALAM MANAJEMEN KESEHATAN REPRODUKSI

Nurmila Eni Folendra Rosa Anita Rahmawati
Siti Munawaroh Eny Dewi Pamungkas

Editor: Firmina Theresia Kora



BUNGA RAMPAI KEPERAWATAN KELUARGA DALAM MANAJEMEN KESEHATAN REPRODUKSI

Penulis:

Nurmila, SST., M.Kes.

Eni Folendra Rosa, SKM., MPH.

Ns. Anita Rahmawati, M.Kep.

Ns. Siti Munawaroh, M.Kep.

Ns. Eny Dewi Pamungkas, M.Kep, Sp.Kep.M.

Editor:

Firmina Theresia Kora., S.Kep. Ns., M.P.H.



Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Manajemen Kesehatan Reproduksi

Penulis: Nurmila, SST., M.Kes.

Eni Folendra Rosa, SKM., MPH.

Ns. Anita Rahmawati, M.Kep.

Ns. Siti Munawaroh, M.Kep.

Ns. Eny Dewi Pamungkas, M.Kep, Sp.Kep.M.

Editor: Firmina Theresia Kora., S.Kep. Ns., M.P.H.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-29-9

Cetakan Pertama: April 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Manajemen Kesehatan Reproduksi ini dapat disusun dan hadir sebagai salah satu sumber literatur yang diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi keperawatan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap isu kesehatan reproduksi dalam lingkup keluarga. Buku ini merupakan himpunan karya ilmiah dari para akademisi dan praktisi keperawatan yang menggambarkan pentingnya peran keluarga dalam setiap fase kehidupan reproduksi, mulai dari masa remaja hingga pemulihan pasca keguguran.

Isi buku ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas tema-tema krusial dalam manajemen kesehatan reproduksi, dengan pendekatan keperawatan keluarga sebagai benang merahnya. Bab pertama menyoroti pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja dalam keluarga. Bab kedua mengulas dukungan keluarga dalam proses menyusui, sementara bab ketiga membahas pentingnya peran keluarga dalam mendampingi perempuan selama masa puerperium. Bab keempat menggambarkan bagaimana keluarga dapat mendukung remaja menghadapi perubahan fisik, dan bab kelima menutup dengan pemulihan pasca keguguran dari perspektif dukungan emosional dan praktis yang diberikan keluarga.

Kami menyadari bahwa isu kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan terutama keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang mendorong peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta keterlibatan keluarga dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi anggota keluarganya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini memberi manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya nyata dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan di Indonesia.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA, PENDIDIKAN

KESEHATAN UNTUK KELUARGA	1
Nurmila, SST., M.Kes.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Remaja	3
C. Kesehatan Reproduksi Remaja	4
D. Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja	6
E. Cara memelihara kesehatan reproduksi Remaja	10
F. Pendidikan Kesehatan Untuk Keluarga	11
G. Referensi	15
H. Glosarium.....	18

CHAPTER 2 MENYUSUI: PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG IBU

MENYUSUI	21
Eni Folendra Rosa, SKM., MPH.....	21
A. Pendahuluan	21
B. Peran Keluarga Bagi Ibu Menyusui	21
C. Dukungan Keluarga bagi Ibu Menyusui.....	23
D. Dukungan Praktik Menyusui.....	24
E. Simpulan	30
F. Referensi	30

CHAPTER 3 MENDUKUNG KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA

MELAHIRKAN: PERAN KELUARGA DALAM PERAWATAN PUERPERIUM.....	33
Ns. Anita Rahmawati, M.Kep.	33
A. Pendahuluan	33
B. Masa Puerperium	34
C. Pola Hidup Sehat di Masa Puerperium	36
D. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Puerperium	40

E. Peran Keluarga dalam Perawatan Puerperium.....	43
F. Simpulan	46
G. Referensi	46
H. Glosarium.....	49

CHAPTER 4 DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP REMAJA DALAM

MENGHADAPI PERUBAHAN FISIK.....50

Ns. Siti Munawaroh, M.Kep.....	50
A. Pendahuluan/Prolog	50
B. Tahap Tumbuh Kembang Remaja	51
C. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja.....	53
D. Bentuk dan Fungsi Dukungan keluarga	53
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga.....	55
F. Simpulan	56
G. Referensi	57
H. Glosarium.....	58

CHAPTER 5 PERAN KELUARGA DALAM PEMULIHAN PASCA KEGUGURAN ...60

Ns. Eny Dewi Pamungkas, M.Kep, Sp.Kep. M.....	60
A. Memahami Keguguran	60
B. Tahapan Berduka Terhadap Peristiwa Keguguran.....	61
C. Keluarga dan Dukungan Pemulihan Pasca Keguguran	63
D. Dukungan Praktis yang Dapat Diberikan Keluarga	70
E. Langkah-langkah Pemulihan Jangka Panjang	72
F. Referensi	73

PROFIL PENULIS76

CHAPTER 1

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA, PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK KELUARGA

Nurmila, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Masa remaja merupakan suatu periode perkembangan manusia yang melibatkan perubahan biologis, psikologis, dan sosial, di mana terjadi perubahan dan transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Remaja adalah mereka yang sedang menjalani masa transisi di mana mereka berangsur-angsur menjadi dewasa secara seksual, mengalami perubahan psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan mengalami perubahan status ekonomi dari keadaan tergantung menjadi keadaan yang relatif mandiri. Ada dua aspek utama perubahan yang terjadi selama masa pubertas: perubahan fisik atau biologis dan perubahan psikologis. Masa remaja diawali dengan suatu masa pertumbuhan yang sangat pesat yang disebut masa remaja (Kementerian kesehatan, 2022)

Masa pubertas adalah tahap perkembangan di mana alat alat seksual menjadi matang dan kemampuan reproduksi muncul. Di Indonesia, kesehatan reproduksi remaja sangat penting dan menjadi bagian integral dari program kesehatan dan keluarga berencana. Pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, penggunaan alkohol, tembakau, dan HIV/AIDS adalah semua masalah yang difokuskan pada program terpadu ini. Di Indonesia, beberapa studi kesehatan reproduksi remaja mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 15 hingga 24 tahun. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 10 hingga 24 tahun, dan Departemen Kesehatan mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 10 hingga 19 tahun (IDAI, 2019)

Badan pusat statistik tahun 2023, mengestimasi, ada 64,16 juta pemuda di Indonesia, Jumlah itu setara dengan 23,18% dari total penduduk di tanah air. Ditinjau dari kelompok umurnya, pemuda Indonesia paling banyak berada di kelompok umur 19-24 tahun, yakni 39,78%. Sebanyak 39,05% pemuda berasal dari kelompok umur 25-30 tahun dan 21,17% pemuda berusia 16-18 tahun. Menurut hasil survey Youth Risk Behavior Survey (YRBS) tahun 2020, banyak remaja melakukan perilaku seksual yang berbahaya. Di Amerika Serikat, remaja berusia 13-14 tahun mengalami HIV dan hampir 20 juta kasus baru PMS yang dilaporkan pada remaja berusia 15 hingga 24 tahun. Di Indonesia, 2,4% remaja berusia 10 hingga 19 tahun dan 8,6% remaja berusia 20 hingga 24 tahun yang belum menikah pernah

melakukan hubungan seks pranikah (Data Survei Kesehatan Reproduksi Indonesia, 2021)

Masalah kesehatan reproduksi yang terjadi pada alat kelamin remaja disebabkan oleh kurangnya perhatian dan usia yang relatif muda. Kaum muda yang masih mencari jati diri dapat dengan mudah memperoleh informasi dari berbagai sumber. Pendidikan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dapat menyebabkan remaja terlibat dalam perilaku seksual bebas. Dalam hal ini, peran orang tua sebagai pendidik menjadi penting untuk membatasi akses media pada informasi yang kurang akurat. Remaja perlu memperoleh informasi yang akurat dan tepat tentang kesehatan reproduksinya sehingga mereka dapat menghindari praktik seksual yang dapat membahayakan kesehatan (Agustina, 2024)

Saat ini Remaja sangat rentan terhadap informasi yang salah terkait topik kesehatan reproduksi. Tanpa bimbingan dan pendidikan yang tepat tentang kesehatan reproduksi, remaja mudah tertipu. Kaum muda membutuhkan pengertian, bimbingan, dan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Perkembangan biologis dan psikologis remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan sosialnya. Keluarga merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku reproduksi remaja. Globalisasi informasi melalui media juga berkontribusi terhadap perubahan perilaku seksual remaja. Eksploitasi seksual di televisi, klip video, media daring, film dan lain-lain telah mendorong banyak anak muda untuk bebas terlibat dalam aktivitas seksual. Mengingat skala masalah dan dampaknya terhadap generasi mendatang, kita perlu memberikan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada remaja dalam berbagai bentuk, dimulai dari rumah sedini mungkin, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang sehat. Fisik, mental dan psikososial (Hamdani et al., 2021)

Persiapan menghadapi pubertas harus dimulai dari pemberian motivasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan sistem reproduksi, mengidentifikasi kemungkinan masalah selama pubertas yang berkaitan dengan perkembangan fungsi seksual, dan memberikan informasi mengenai perkembangan dan perubahan kesehatan reproduksi selama pubertas. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan kesehatan mengenai Layanan kesehatan reproduksi yang berfokus pada komunikasi, informasi, pendidikan dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi. Program tersebut mencakup pendidikan tentang sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan konsekuensinya, keluarga berencana, dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan (PANrb, 2024)

Peran dan keterlibatan orang tua dalam perkembangan reproduksi remaja sangat penting untuk mencegah remaja terlibat dalam perilaku berisiko. Karena remaja masih kurang dalam pemahaman dan pengalaman terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, maka menjadi tanggung jawab orang tua untuk membimbingnya. Banyak faktor yang menghambat perkembangan remaja, seperti disabilitas psikologis dan fisik, serta pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial, sehingga proses perkembangan individu tidak selalu berjalan mulus (Noor Syahadatina et al., 2020)

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah kesehatan reproduksi remaja antara lain dengan memberikan pendidikan kesehatan mengenai perkembangan pubertas, cara merawat alat reproduksi, edukasi terhadap dampak pornografi, dampak kehamilan tidak diinginkan (KTD), aborsi, dan pendidikan kesehatan tentang HIV./AIDS, usia yang tepat untuk menikah, pencegahan terhadap penyakit menular seksual dengan melibatkan pemerintah, orang tua, dan kelompok sebaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyadarkan remaja akan pentingnya masalah kesehatan reproduksi, dan mengurangi kejadian masalah kesehatan reproduksi di kalangan remaja (Isni et al., 2020)

Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja sangatlah penting. Kesehatan reproduksi remaja adalah kemampuan untuk menikmati kehidupan seksual dan menjalankan fungsi dan proses reproduksi dengan cara yang sehat dan aman. Kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual remaja dapat sangat merugikan bagi remaja itu sendiri dan keluarga mereka karena perkembangan kognitif, emosional, sosial dan seksual yang penting terjadi selama masa ini. Perkembangan ini terjadi antara usia 12 dan 20 tahun. Kurangnya pemahaman tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adat istiadat, budaya, agama, serta minimnya informasi dari sumber yang dapat dipercaya (Astuti, 2021)

B. Remaja

Masa remaja adalah periode penting yang menghubungkan fase anak-anak dan kedewasaan, di mana remaja mencari identitas diri dan mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan, termasuk pubertas. Perubahan ini sering kali membuat remaja merasa bingung dan terkejut. Selain itu, masa remaja juga rentan terhadap perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan perilaku seksual yang tidak sehat, yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan masa depan mereka (Mulyati et al., 2024).

Dalam hal fisik, periode remaja ditandai dengan adanya perubahan ciri-ciri penampilan dan fungsi fisiologis, terutama yang berhubungan dengan organ reproduksi, sedangkan dari sisi psikologis, masa remaja merupakan saat individu mengalami perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral, peralihan masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Masa remaja dibagi menjadi tiga tahap remaja awal 10-13 tahun, remaja tengah 14-16 tahun, dan remaja akhir 17-19 tahun. Kesehatan reproduksi menjadi aspek utama dalam masa ini (Mulyati et al., 2024).

Masa remaja awal disebut juga tahap pubertas, Hal ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti media massa dan kelompok sebaya. Pada tahap ini, remaja yang belum stabil cenderung lebih rentan melakukan penyesuaian diri yang kurang tepat dibandingkan dengan remaja yang lebih stabil. Salah satu perilaku khas remaja adalah sikap kritis, di mana mereka menuntut segala sesuatu untuk dijelaskan secara rasional, sehingga sering mempertanyakan aturan yang ada. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi memicu kebutuhan untuk mencari jawaban atas berbagai hal, sementara pola pikir yang egosentris dapat membuat mereka menentang pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Kestabilan emosi dan perilaku dapat dicapai melalui bimbingan dan dukungan dari orang tua, guru, atau orang-orang di sekitarnya (Fitriani et al., 2024).

C. Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Definisi Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Hal ini menegaskan bahwa kesehatan tidak hanya diukur dari kondisi fisik, mental, dan sosial semata, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas produktif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi, yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, bukan sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan, melainkan juga melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya (Yarza et al., 2019).

Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. tidak semata-mata bebas penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial-kultural (Sari, 2020).

Kesehatan reproduksi menjadi hal yang perlu diperhatikan, khususnya pada remaja, sebab hal ini dapat menurunkan tingkat kematian dan kesakitan remaja saat ini, mengurangi beban penyakit di masa yang akan datang, menumbuhkan

remaja menjadi pribadi yang sehat baik pada saat ini maupun di masa depan, memenuhi hak manusia, dan melindungi produktivitas remaja. Kesehatan reproduksi dapat dicapai dengan pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi yang benar dan komprehensif, pengetahuan dan sikap tersebut didapatkan melalui berbagai sarana, salah satunya pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi.

2. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi

- a. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
- b. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PMS-HIV/AIDS
- c. Pencegahan dan pengulangan komplikasi aborsi
- d. Kesehatan reproduksi remaja
- e. Pencegahan dan penanganan infertile
- f. Kanker pada usia Lanjut
- g. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya misalnyakanker servik, mutilasi genitalia,fistula, dll.

3. Anatomi dan fisiologi organ reproduksi

Anatomi adalah cabang ilmu yang fokus pada mempelajari struktur tubuh, baik yang dapat dilihat secara langsung (makroskopis) maupun melalui alat bantu seperti mikroskop (mikroskopis). Sementara itu, fisiologi adalah ilmu yang mengkaji bagaimana tubuh berfungsi, baik pada tingkat individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Sistem reproduksi manusia sendiri merupakan sistem biologis yang terdiri dari berbagai organ dan jaringan yang bekerja bersama untuk memungkinkan terjadinya proses reproduksi.(Pratiwi et al., 2024).

Remaja perlu memahami bahwa pria dan wanita memiliki organ reproduksi yang berbeda, baik dari segi struktur maupun fungsi. Organ reproduksi pria meliputi testis dan penis, sementara organ reproduksi wanita terdiri dari Sistem reproduksi wanita terdiri dari internal dan eksternal alat kelamin. Alat kelamin internal terdiri dari ovarium, saluran rahim (fallop), uterus (termasuk leher rahim) dan vagina. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi masing-masing organ reproduksi yang dapat diberikan kepada remaja (Azizah et al., 2023).

a. Testis

Pria memiliki dua buah testis yang terbungkus oleh lapisan yang disebut skrotum. Berfungsi sebagai kantong kulit khusus yang melindungi testis dan epididimis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. Testis ditutupi oleh lapisan padat dari jaringan fibrosa putih yang disebut tunica albuginea. Lapisan ini meluas ke arah dalam dan membagi masing-masing testes memiliki kira-kira 200-300 tubulus yang terdiri atas satu sampai tiga buah tubula yang

rapat dan membentuk koil dan disebut tubula seminiferus. Testis adalah organ penghasil sel-sel sperma pada tubuh pria. Organ ini juga merupakan tempat sekresi hormon testosteron.

b. Penis

Penis adalah alat reproduksi pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni (urin). Penis tersusun atas 3 jenis jaringan erektile, yaitu satu korpus spongiosum dan dua korpora kavernosa, yang dilapisi oleh jaringan tunika albuginea. Saluran yang ada pada struktur penis disebut juga uretra. Uretra tidak hanya berfungsi mengalirkan cairan mani, tetapi juga untuk mengalirkan urine saat berkemih.

c. Ovarium

Setiap wanita memiliki satu pasang ovarium. Besar ovarium kurang lebih sebesar ibu jari tangan dengan ukuran kira-kira 4 cm, lebar dan tebal kira-kira 1,5 cm. Ada dua ligamentum yang menggantung ovarium yaitu Ligamentum ovarii proprium yang menggantung ke uterus dan Ligamentum suspensorium ovarii (infundibulopelvikum) yang menggantung ke dinding lateral panggul. Ovarium atau disebut juga indung telur adalah organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum. Ovarium juga mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron.

d. Uterus

Uterus atau rahim adalah tempat menempelnya sel telur yang sudah matang dan bertemu dengan sperma, yang kemudian akan bertumbuh menjadi janin. Apabila sedang tidak terjadi pembuahan, dinding rahim bagian dalam (endometrium) akan meluruh dan mengelupas, dan proses ini disebut dengan menstruasi atau datang bulan.

e. Vagina

Vagina adalah saluran muskulomembran yang membentang dari vulva ke serviks uterus. vagina berhubungan erat ke kandung kemih dan uretra. Uretra terletak pada dua pertiga bagian bawah vagina dan trigonum kandung kemih terhadap sepertiga bagian atas. Jaringan memisahkan struktur ini disebut septa urethrovaginal dan vesicovaginal, masing-masing, dan terdiri dari jaringan pendukung fascia endopelvic. Panjang vagina biasanya 8-10 cm. Otot-otot perineum menyebabkan relatif penyempitan diameter outlet. Vagina diratakan saat santai, menciptakan hanya ruang potensial, tetapi memiliki kemampuan luar biasa untuk buncit, misalnya selama proses persalinan, untuk mengakomodasi perjalanan janin.

D. Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja

Globalisasi memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, yang pada gilirannya memengaruhi dan mengubah gaya hidup mereka. Perubahan ini berkontribusi pada meningkatnya kasus masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Masalah kesehatan reproduksi remaja mencakup perilaku seksual beresiko antara lain seks pra nikah yang dapat berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan, perilaku seksual berganti ganti pasangan, aborsi tidak aman, dan perilaku beresiko tertular infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV (Irfan et al., 2023)

1. Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan aborsi

Berdasarkan data WHO tahun 2019 terdapat 55% kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja perempuan yang mayoritas berusia 15–19 tahun berakhir dengan aborsi, Kehamilan tidak diinginkan (KTD) adalah kehamilan yang terjadi tanpa perencanaan, baik karena waktu yang tidak tepat atau karena tidak diinginkan. Aborsi, yang dalam bahasa Inggris disebut *abortion* dan dalam bahasa Latin disebut *abortus*, mengacu pada pengguguran kandungan. (Gultom et al., 2024).

Unwanted preagnancy atau di kenal sebagai kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Kehamilan ini bisa merupakan akibat dari suatu perilaku seksual atau hubungan seksual baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Faktor-faktor penyebab Unwanted Pregnancy. Banyak faktor yang menyebabkan unwanted pregnancy yaitu penundaan dan peningkatan usia perkawinan, serta semakin dininya usia menstruasi pertama (menarche), ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan, kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan, persoalan ekonomi (biaya untuk melahirkan dan membesarkan anak) dan kehamilan karena incest (Munthe, 2024).

Remaja yang hamil sering menghadapi tantangan psikososial, seperti stres akibat kehamilan yang tidak diinginkan, ketidaksiapan menjadi orang tua, kurangnya pendapatan, serta risiko komplikasi persalinan. Mencegah kehamilan pada remaja dan menurunkan angka kematian serta kesakitan terkait kehamilan menjadi kunci untuk meningkatkan kesehatan jangka panjang. Di Indonesia, tingginya angka kematian ibu dan anak banyak disebabkan oleh perkawinan anak dan kehamilan di usia remaja. Oleh karena itu, edukasi tentang proses kehamilan, persiapan yang diperlukan, dan risiko yang mungkin terjadi sangat penting untuk membantu remaja merencanakan kehamilan dengan baik dan mencegah kehamilan di usia dini (Siahaan et al., 2024).

2. Penyakit menular seksual dan HIV/AIDS

a. Gonore

Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*. Gonore biasa juga disebut dengan kencing nanah. Kencing nanah dapat menyebabkan infeksi pada saluran uretra, anus, vagina atau kencing nanah dapat ditularkan melalui seks anal, oral, maupun vaginal. berikut gejala gonore yang terjadi pada perempuan yaitu terasa nyeri dipanggul, terutama saat melakukan hubungan seksual, adanya pendarahan yang tidak teratur, timbulnya keputihan yang tidak biasa, sedangkan pada Laki-laki timbulnya rasa nyeri ditenggorokan, keluarnya cairan yang berasal dari anus, timbul kemerahan pada ujung penis, dan keluarnya cairan putih atau kuning yang pekat. Pemeriksaan gonore dengan cara mengusap dan mengambil cairan pada uretra dan serviks, pemeriksaan gonor juga bisa dilihat dari urin penderita gonore. Pengobatan gonore adalah dengan antibiotic yang tepat (Ramadani & Fitri, 2021).

b. Sifilis

Sifilis adalah penyakit menular seksual yang menyerang laki-laki. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *treponema pallidum*. Seseorang yang menderita sifilis lebih parah bisa menyebabkan infeksi otak dan kecacatan tubuh (guma), penderita sifilis sangat rentan untuk terkena HIV. Sifilis dibedakan menjadi dua tipe, yaitu sifilis kongenital, dimana penderita sifilis kongenital dapat ditularkan dari ibu ke janin selama dalam masa mengandung. Selanjutnya sifilis acquired, yaitu sifilis yang didapatkan dari hubungan seksual bebas, dan pemakaian suntik secara bersamaan (Ramadani & Fitri, 2021).

Gejala sifilis meliputi rasa nyeri pada tulang dan sendi, ruam yang biasanya muncul di telapak tangan dan kaki, adanya pembengkakan getah bening pada pangkal paha. ditemukan bercak-bercak diseluruh tubuh, adanya luka pada kelamin, rektum, bibir, dan juga lidah. Meskipun gejala sifilis dapat menghilang sewaktu-waktu, infeksi tetap ada dalam tubuh. Jika tidak diobati, sifilis dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk gangguan mental. Pengobatan sifilis dilakukan dengan pemberian antibiotik yang harus segera dimulai untuk mencegah perkembangan penyakit (Ramadani & Fitri, 2021).

c. Herpes genitalis

Herpes genitalis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simpleks tipe 1 (HSV-1) atau tipe 2 (HSV-2) dengan perbedaan genetika. Penularan herpes lebih sering terjadi pada laki-laki ke pasangan perempuannya. Virus herpes dapat menular melalui gelembung herpes yang pecah, penularannya melalui kontak dengan kulit yang terkena virus herpes.

Pada herpes genital hanya bisa ditularkan melalui hubungan seksual baik seks anal, oral, maupun vaginal (Ramadani & Fitri, 2021).

Gejala yang ditimbulkan adalah munculnya bintil-bintil berair dan berkelompok yang nyeri di sekitar alat kelamin, dan kemudian dapat pecah, mengering dan menghilang. Bintil-bintil ini dapat kambuh kembali apabila ada faktor pencetus, dan umumnya akan hilang timbul seumur hidup. Herpes genital memiliki dampak signifikan pada kehamilan karena dapat meningkatkan risiko keguguran dan kelahiran prematur. Pengobatan biasanya melibatkan pemberian obat antivirus yang dikonsumsi secara rutin untuk mengendalikan infeksi. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari hubungan seksual berisiko, serta bagi penderita herpes genitalis disarankan untuk menunda aktivitas seksual sampai kondisi terkendali (Ramadani & Fitri, 2021).

d. HIV /AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sel darah putih. Virus yang ditemukan oleh Montagnier ini akan mengakibatkan penurunan imun bagi yang terserang virus ini. Penderita HIV akan selalu mengonsumsi obat seumur hidupnya. Fase akhir dari infeksi HIV disebut AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), yang merupakan kumpulan penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh yang sangat rendah, seperti tuberkulosis, pneumonia, dan infeksi jamur sistemik. Virus ini menular melalui cairan tubuh, yaitu darah, sperma, dan air susu ibu. Jalur transmisi HIV adalah melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan berganti-gantian pada penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang, transfusi darah dari orang yang terinfeksi, serta transmisi ibu ke anak melalui plasenta (in utero), jalan lahir, maupun air susu ibu (Widiastuti et al., 2024).

HIV/AIDS adalah pandemi global yang terdiri dari sejumlah besar epidemi lokal yang didorong secara nasional oleh perilaku manusia dan kondisi masyarakat yang bervariasi namun serupa. Epidemi HIV di Indonesia merupakan jenis epidemi terkonsentrasi dan telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade yang terkonsentrasi pada 4 populasi kunci yaitu lelaki seks dengan lelaki (LSL), waria (transgender), pekerja seks perempuan (PSP) dan pengguna narkoba suntik (penasun) (Widiastuti et al., 2024).

Kasus HIV pada remaja sering kali berkaitan dengan gaya hidup yang meniru budaya barat, seperti kumpul kebo, penggunaan narkoba, konsumsi alkohol berlebihan, dan aktivitas seksual sebelum menikah. Kenakalan remaja memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi mereka. Sifat alami remaja yang cenderung menyukai hal-hal baru sering kali mendorong

mereka untuk melakukan berbagai tindakan demi terlihat lebih unggul atau lebih diterima di lingkungan pergaulannya (Ramadani & Fitri, 2021).

E. Cara memelihara kesehatan reproduksi Remaja

Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait perilaku yang mendukung kesehatan reproduksi. Salah satu aspek penting adalah menjaga kebersihan organ seksual, yang sering kali kurang diperhatikan dibandingkan organ tubuh lainnya. Padahal, organ seksual memerlukan perawatan khusus karena menghasilkan keringat dalam jumlah cukup banyak, sehingga cenderung lebih lembap. Kondisi ini dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, menyebabkan penyakit, dan menimbulkan bau yang tidak sedap (Emilda, 2021).

Organ reproduksi merupakan hal yang sangat vital, maka perlu dijaga kesehatannya. Terlebih lagi apabila kita masih di usia remaja, menjaga kesehatan organ reproduksi sangatlah penting. Masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik menjaga kebersihan, yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi yang benar terhadap hal ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal hal yang tidak diinginkan (Wardiyah et al., 2022).

1. Pada wanita, cara memelihara kesehatan organ reproduksi yang dianjurkan adalah dengan tidak memasukkan benda-benda asing ke dalam vagina, ganti celana dalam minimal 2x sehari. Pilih celana dalam yang mudah menyerap keringat, misalnya bahan katun. Hindari celana dalam yang terlalu ketat karena akan menekan otot vagina dan membuat suasana lembab yang dapat memicu pertumbuhan jamur .
2. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Akibatnya, muncul gatal-gatal di area organ intim.
3. Saat sedang membersihkan saluran kemih dan saluran pencernaan (anus), perlu diperhatikan bahwa arah yang benar adalah dari depan ke belakang, sehingga menghindari kuman dari saluran cerna masuk ke dalam saluran kemih. Air yang digunakan juga diusahakan sebersih mungkin.
4. Menjaga organ reproduksi agar tidak lembap. Pastikan untuk mengeringkan area kelamin menggunakan handuk yang lembut, kering dan bersih setiap diperlukan.
5. Pada pria, prinsip pemeliharaan kesehatan reproduksi umumnya sama dengan wanita, tetapi yang penting adalah perlunya melakukan sunat, untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis (smegma) sehingga alat kelamin

menjadi lebih bersih. Glans penis harus selalu dibersihkan dari sisa urin setiap selesai berkemih.

6. Baik pria maupun wanita disarankan untuk rutin mencukur bulu pubis atau rambut kemaluan. Kebiasaan ini penting untuk mencegah pertumbuhan kutu dan jamur yang dapat menyebabkan rasa gatal serta ketidaknyamanan.
7. Menghindari aktivitas seksual yang berisiko. Pemahaman tentang aktivitas seksual yang berisiko adalah hal yang penting. Aktivitas seksual berisiko memiliki beragam bentuk mulai dari hubungan seksual tanpa kontrasepsi hingga berganti-ganti pasangan. Kedua aktivitas ini sama-sama memiliki risiko tinggi menularkan penyakit seksual.

F. Pendidikan Kesehatan Untuk Keluarga

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga berfungsi sebagai sumber utama bimbingan dan dukungan bagi remaja dalam situasi kehidupan tertentu untuk membantu mereka melewati masa ini dengan sukses. Karena anak-anak kurang memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap diri mereka sendiri dan lingkungannya, maka menjadi tanggung jawab orang tua untuk membimbing mereka. Proses perkembangan remaja tidaklah mulus dan terhambat oleh banyak faktor, antara lain gangguan psikis dan fisik, serta pengaruh lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (Hikmandayani, 2021).

Menurut Meitria et al, 2020, Layanan kesehatan reproduksi saat ini berfokus pada penyediaan pendidikan kesehatan melalui metode komunikasi, informasi, dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Peran dan keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anaknya tentang kesehatan reproduksi sangatlah penting. Ini dimulai dengan keterampilan komunikasi orang tua. Ketika berkomunikasi dengan remaja, banyak masalah muncul karena orang tua tidak mampu memahami perasaan lawan bicaranya. Agar komunikasi lebih efektif, orang tua perlu meningkatkan keterampilan mereka dan mencoba memahami perasaan anak remaja mereka sebagai lawan bicara. Komunikasi antara orang tua dan remaja adalah pemindahan informasi atau pesan dari komunikator (orang tua) kepada penerima (remaja). Komunikasi antara orang tua dan remaja harus mencakup penyampaian nilai-nilai, norma-norma, dan sikap orang tua mengenai kesehatan reproduksi remaja. Tujuan dilakukannya komunikasi efektif orangtua dengan remaja, antara lain:

1. Membangun hubungan yang harmonis dengan remaja.
2. Membentuk suasana keterbukaan.
3. Membuat orang tua mau mendengar remaja saat mereka berbicara.
4. Membuat remaja mau bicara pada saat mereka menghadapi masalah.

5. Membuat remaja mau menghormati orangtua atau orang dewasa saat mereka berbicara.
6. Membantu remaja menyelesaikan masalahnya.

Beberapa hal yang sering dilakukan orangtua ketika berkomunikasi dengan remaja, sehingga menghambat keberhasilan komunikasi orangtua dengan remaja, antara lain:

1. Lebih banyak berbicara daripada mendengar.
2. Merasa tahu lebih banyak.
3. Cenderung memberi arahan dan nasihat.
4. Tidak berusaha untuk mendengar terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dan yang dialami oleh remaja.
5. Tidak memberi kesempatan pada remaja untuk mengemukakan pendapat.
6. Tidak mencoba menerima kenyataan yang dialami remaja dan memahaminya.
7. Merasa putus asa dan marah karena tidak tahu harus bersikap atau bertindak bagaimana kepada remajanya.

Komunikasi akan lebih efektif jika orangtua meningkatkan kemampuannya dan mencoba memahami perasaan remaja sebagai lawan bicara. Pada dasarnya kebutuhan manusia yang paling dalam adalah keinginan agar perasaannya dimengerti, didengar, dihargai, dan dirinya dapat diterima oleh orang lain karena perasaan memegang peranan yang sangat penting dalam berkomunikasi. Seseorang yang sedang dalam perasaan senang akan mudah berkomunikasi, menerima dan menyampaikan pikiran, pendapat, bahkan perasaan hatinya

Salah satu upaya yang dilaksanakan dan dipromosikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepedulian tentang kesehatan reproduksi remaja adalah program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). PIK Remaja merupakan kegiatan program GenRe (Generasi Berencana) yang dikembangkan oleh BKKBN dan dijalankan oleh remaja dan pelajar, yang memberikan informasi dan pelatihan mengenai perkembangan usia menikah, delapan fungsi keluarga, dan TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS). layanan konseling. menyediakan. dan narkotika.), keterampilan hidup, keterampilan genre dan advokasi, dan IEC. Kepala Pusat Informasi dan Konseling Remaja dapat berupa orang yang memiliki minat khusus terhadap isu-isu remaja, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi remaja/kepemudaan, atau orang tua. Kegiatan utama dari PIK remaja adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja mengenai IMS, HIV/AIDS, dan bahaya Napza. Pelayanan tentang informasi kesehatan remaja menjelaskan tentang alat-alat reproduksi pada pria maupun wanita, serta mengenali gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada

alat reproduksi, menjelaskan pengertian dari HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan penyebab rusaknya/lemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini berada dalam cairan tubuh manusia seperti darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Namun tidak semua cairan dalam tubuh manusia memiliki HIV. Informasi Napza dapat dijelaskan dengan mengetahui jenis-jenis Napza dan dampaknya bagi tubuh atau kesehatan.

2. Pelayanan konseling remaja dan rujukan

Pelayanan konseling yang diberikan kepada individu remaja, harus dilakukan oleh tenaga profesional, oleh karena itu konselor harus mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai dan terlatih, sehingga dalam melaksanakan pelayanan benar-benar profesional. Rujukan dari pelayanan konseling pada umumnya adalah Puskesmas, Rumah Sakit, kepolisian, Kantor Kementerian Agama/KUA, Komisi Penanggulangan AIDS, Badan Narkoba Kabupaten, Koramil.

3. Pendidikan keterampilan hidup (*life skill education*)

Keterampilan hidup adalah memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional untuk bekerja serta berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraaannya secara mandiri.

Selain program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Pemerintah juga meluncurkan program GenRe (Generasi Terencana) yang dikembangkan oleh BKKBN. Program ini dikelola oleh pemuda/mahasiswa dan menyediakan layanan informasi dan konsultasi. Salah satu bentuk kegiatan yang dikembangkan program GenRe adalah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang sasarannya adalah keluarga dengan remaja usia 10-24 tahun. Tujuan dari kegiatan BKR adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya serta untuk mendorong perkembangan anak dan remaja melalui komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja baik dalam perkembangan fisik, intelektual, reproduksi dan spiritual. Tujuannya adalah untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang Emosional, sosial, spiritual dan moral. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan jawaban atas keresahan kaum muda di era globalisasi saat ini akibat pesatnya perkembangan media. Kami mempersiapkan keluarga remaja dan dewasa muda untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang positif.

Menurut (Kemenkes RI, 2018), Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan reproduksi meliputi:

1. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan proses tumbuh kembangnya.

2. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja dilakukan melalui pola intervensi di sekolah formal maupun non formal dan di luar sekolah dengan memakai pendekatan "pendidik sebaya" atau *peer counselor*, KKR.
3. Menjaga tubuh (terutama organ / alat reproduksi) dari pandangan dan sentuhan orang lain.
4. Bedakan rahasia yang baik dan rahasia yang buruk. Setiap rahasia yang membuatmu merasa gelisah, tidak nyaman, ketakutan dan sedih adalah rahasia yang buruk dan tidak patut untuk disimpan, melainkan harus diberitahukan pada orang tua atau orang dewasa yang dipercayai. Pelaku pelecehan seksual seringkali menggunakan taktik dan berbagai macam alasan dengan tujuan utamanya agar kamu merahasiakan hal tersebut dari orang tua/orang lain supaya ia bebas dari hukuman.
5. Bicarakan dengan orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya, apabila kamu merasa khawatir, sedih, atau merasa mendapatkan perlakuan pelecehan seksual atau kekerasan dari orang lain.
6. Bereaksilah terhadap perlakuan yang tidak pantas/tidak wajar dengan mengungkapkan dan melaporkan perilaku kejahatan dari orang di sekitarmu. Banyak kasus, pelaku pelecehan/kekerasan adalah seseorang yang dikenal, berhati-hatilah dengan pemberian hadiah dari orang yang dikenal atau tidak dikenal. Beritahu orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai apabila ada orang yang selalu memberimu hadiah. Tidak boleh dirahasiakan apabila ada yang memintamu menyimpan rahasia dan berusaha untuk berduaan saja denganmu.
7. Laporkan pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai apabila ada seseorang yang ingin melihat/menyentuh area pribadimu. Yakinkan mereka untuk segera mengambil tindakan untuk membantumu. Kamu juga harus memiliki nomor telepon orang dewasa yang kamu percayai untuk dihubungi bila dalam keadaan darurat.
8. Hindari Seks Pranikah
Remaja perempuan yang sudah menstruasi, berisiko hamil apabila melakukan hubungan seksual dan remaja laki-laki yang telah mengalami mimpi basah sudah bisa menyebabkan kehamilan jika melakukan hubungan seksual.
9. STOP pornografi
Pornografi merupakan salah satu faktor resiko yang membuat perilaku seksual menyimpang dan mendorong risiko terjadinya kekerasan seksual (*sexual abuse*). Pornografi dapat merusak otak yang berperan di dalam kontrol perilaku yang menimbulkan perbuatan berulang-ulang terhadap pemuasan seksual.

10. Menjaga kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas Remaja disabilitas memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan perhatian lebih, terutama dari keluarga, sekolah, teman sebaya dan masyarakat lingkungannya.

G. Referensi

- Agustina, E. all. (2024). Buku Kesehatan Reproduksi Remaja. Eureka Media Aksara, 25. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>
- Agustina, E. all. (2024). Buku Kesehatan Reproduksi Remaja. Eureka Media Aksara, 25. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>
- Azizah, N., Riana, E. N., Megasari, M. A. L., Arhesa, S., Saputri, I. N., Syafriana, V., & Perestroika, G. D. (2023). Fisiologi Sistem Reproduksi.
- Azizah, N., Riana, E. N., Megasari, M. A. L., Arhesa, S., Saputri, I. N., Syafriana, V., & Perestroika, G. D. (2023). Fisiologi Sistem Reproduksi.
- Badan pusat statistik. (2023). Data Jumlah Pemuda di Indonesia pada 2023. Data Indonesia ID, 1–12.
- Badan pusat statistik. (2023). Data Jumlah Pemuda di Indonesia pada 2023. Data Indonesia ID, 1–12.
- Emilda, S. (2021). Analisis Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan, 11(21), 93–101.
- Emilda, S. (2021). Analisis Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan, 11(21), 93–101.
- Fitriani, I., Atika, S., Hs, S., & Dewi, N. R. (2024). Penerapan Pendidikan Kesehatan Tentang Perineal Hygiene Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Di Uptd Puskesmas Purwosari Kecamatan Metro Utara. Jurnal Cendikia Muda, 4(4), 552–557.
- Fitriani, I., Atika, S., Hs, S., & Dewi, N. R. (2024). Penerapan Pendidikan Kesehatan Tentang Perineal Hygiene Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Di Uptd Puskesmas Purwosari Kecamatan Metro Utara. Jurnal Cendikia Muda, 4(4), 552–557.
- Gultom, R., Sebayang, W. B., & Sitanggang, H. (2024). Study Mixed Methods Ppnmss (Perceived Prenatal Maternal Stress Scale) Terhadap Tingkat Stres Ibu Remaja Dengan Ktd (Kehamilan Tidak Diinginkan). 10(2), 110–118.
- Gultom, R., Sebayang, W. B., & Sitanggang, H. (2024). Study Mixed Methods Ppnmss (Perceived Prenatal Maternal Stress Scale) Terhadap Tingkat Stres Ibu Remaja Dengan Ktd (Kehamilan Tidak Diinginkan). 10(2), 110–118.
- Hamdani, A., Derullisa, J., & Muhanan, S. (2021). Peran Orang Tua dalam Memberikan Pemahaman Kesehatan Reproduksi. Prosiding SEMNAS BIO 2021 Universitas Negeri Padang, 380–388.

- Hamdani, A., Derullisa, J., & Muhanan, S. (2021). Peran Orang Tua dalam Memberikan Pemahaman Kesehatan Reproduksi. *Prosiding SEMNAS BIO 2021 Universitas Negeri Padang*, 380–388.
- Hikmandayani. (2021). Psikologi Perkembangan Remaja.
- Hikmandayani. (2021). Psikologi Perkembangan Remaja.
- IDAI. (2019). Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Aspek Sosial. *Kesehatan*, 4–7.
- IDAI. (2019). Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Aspek Sosial. *Kesehatan*, 4–7.
- Irfan, Risyati, L., & Handayani, F. (2023). Pemberdayaan Remaja Dalam Optimalisasi Peningkatan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(1), 104–116.
- Irfan, Risyati, L., & Handayani, F. (2023). Pemberdayaan Remaja Dalam Optimalisasi Peningkatan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(1), 104–116.
- Isni, K., Fantika, F., Saputri, N. A., & Lestari, E. (2020). Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kecamatan Jetis, Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 31–36. <https://doi.org/10.12928/jp.v4i1.1520>
- Isni, K., Fantika, F., Saputri, N. A., & Lestari, E. (2020). Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kecamatan Jetis, Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 31–36. <https://doi.org/10.12928/jp.v4i1.1520>
- Kemenkes RI. (2018). Buku KIE Kader Kesehatan Remaja. In Kementrian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2018). Buku KIE Kader Kesehatan Remaja. In Kementrian Kesehatan RI.
- Kementerian kesehatan. (2022). Kesehatan Reproduksi Remaja : Permasalahan dan Upaya Pencegahan. *Yankes.Kemkes.Go.Id*, 1–1. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan
- Kementerian kesehatan. (2022). Kesehatan Reproduksi Remaja : Permasalahan dan Upaya Pencegahan. *Yankes.Kemkes.Go.Id*, 1–1. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan
- Mulyati, S., Mahanani, D., Hendrik, J., Marasi, S., Fakhirah, A., Fatimah, G. N., Masruroh, S., Syakuli, A. I., Adriansyah, M., & Fasa, S. P. (2024). Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Jakarta. *5(2)*, 200–206.

- Mulyati, S., Mahanani, D., Hendrik, J., Marasi, S., Fakhirah, A., Fatimah, G. N., Masruroh, S., Syakuli, A. I., Adriansyah, M., & Fasa, S. P. (2024). Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Jakarta. 5(2), 200–206.
- Munthe, D. P. (2024). Buku Ajar Kesehtan Reproduksi dan Keluarga (S. P. Tampubolon & I. W. G. Suarjana (eds.)). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Munthe, D. P. (2024). Buku Ajar Kesehtan Reproduksi dan Keluarga (S. P. Tampubolon & I. W. G. Suarjana (eds.)). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Noor Syahadatina, M., Husaini, Puteri, A. O., Rosadi, D., Anhar, V. Y., Laily, N., Yulidasari, F., Sari, A. R., Rahman, F., Setiawan, M. I., Anggraini, L., Hadianor, & Fatimah, H. (2020). Panduan Kesehatan Pada Reproduksi Remaja. In Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI) (Vol. 4, Issue 1).
- Noor Syahadatina, M., Husaini, Puteri, A. O., Rosadi, D., Anhar, V. Y., Laily, N., Yulidasari, F., Sari, A. R., Rahman, F., Setiawan, M. I., Anggraini, L., Hadianor, & Fatimah, H. (2020). Panduan Kesehatan Pada Reproduksi Remaja. In Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI) (Vol. 4, Issue 1).
- PANrb. (2024). PP 28 / 2024 : Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah. 2024–2025.
- PANrb. (2024). PP 28 / 2024 : Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah. 2024–2025.
- Pratiwi, A. M., Ariningtyas, N., Sari, A. I., Puspitasari, R. S., Adhisty, Y., Fitria, Devitasari, I., Pratiwi, F., Ningsih, H., Widarti, S., Husna, F., Pratiwi, B. R., Nasrun, E. K., & Skania, P. C. (2024). Asuhan Komprehensif Kebidanan Kehamilan (Farming & Hikmandayani (eds.); Vol. 4, Issue 1).
- Pratiwi, A. M., Ariningtyas, N., Sari, A. I., Puspitasari, R. S., Adhisty, Y., Fitria, Devitasari, I., Pratiwi, F., Ningsih, H., Widarti, S., Husna, F., Pratiwi, B. R., Nasrun, E. K., & Skania, P. C. (2024). Asuhan Komprehensif Kebidanan Kehamilan (Farming & Hikmandayani (eds.); Vol. 4, Issue 1).
- Puji Tri Astuti¹⁾, E. R. & M. S. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(8), 1663–1668.
- Puji Tri Astuti¹⁾, E. R. & M. S. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(8), 1663–1668.
- Ramadani, M., & Fitri, D. (2021). Remaja dalam Bingkai Kesehatan Reproduksi: Masalah dan Solusi.
- Ramadani, M., & Fitri, D. (2021). Remaja dalam Bingkai Kesehatan Reproduksi: Masalah dan Solusi.

- Siahaan, A., Handoyo, D., Theresa, G., Mahdiyana, G., & Batubara, A. (2024). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kehamilan Tidak Diduga pada Remaja Untuk Menghindari Aborsi. 2(2), 1000–1014.
- Siahaan, A., Handoyo, D., Theresa, G., Mahdiyana, G., & Batubara, A. (2024). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kehamilan Tidak Diduga pada Remaja Untuk Menghindari Aborsi. 2(2), 1000–1014.
- Wardiyah, A., Aryanti, L., Marliyana, M., Oktaliana, O., Khoirudin, P., & Dea, M. A. (2022). Penyuluhan kesehatan pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi. JOURNAL OF Public Health Concerns, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.56922/phc.v2i1.172>
- Wardiyah, A., Aryanti, L., Marliyana, M., Oktaliana, O., Khoirudin, P., & Dea, M. A. (2022). Penyuluhan kesehatan pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi. JOURNAL OF Public Health Concerns, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.56922/phc.v2i1.172>
- Widiastuti, T., Hermanto, Rahmawati, Krismiadi, D., Fransiska, M., Dusra, E., Dina, H., Wijayati, W., Raudah, S., Wardiyah, H., Rahmadika, N., Angka, R. N., Nurlina, W. O., Saraswati, K. D., & Alberto, F. (2024). HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual. In A. Eso & Ainurafiq (Eds.), Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Widiastuti, T., Hermanto, Rahmawati, Krismiadi, D., Fransiska, M., Dusra, E., Dina, H., Wijayati, W., Raudah, S., Wardiyah, H., Rahmadika, N., Angka, R. N., Nurlina, W. O., Saraswati, K. D., & Alberto, F. (2024). HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual. In A. Eso & Ainurafiq (Eds.), Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Yarza, H. N., Maesaroh, & Kartikawati, E. (2019). Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual. Sarwahita, 16(01), 75–79. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.08>
- Yarza, H. N., Maesaroh, & Kartikawati, E. (2019). Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual. Sarwahita, 16(01), 75–79. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.161.08>

H. Glosarium

HIV	= <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
AIDS	= <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
BKKBN	= Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
IDAI	= Ikatan Dokter Anak Indonesia
PMS	= Penyakit Menular Seksual

KTD	= Kehamilan Tidak Diinginkan
IMS	= Infeksi Menular Seksual
UTD	= Unwanted Preagnancy
HSV	= Herves Simplex Virus
PSP	=Pekerja Seks Perempuan
Penasun	=Pengguna Narkoba Suntik
Genre	= Generasi Berencana
PIK-R	= Pusat Informasi Konseling Remaja
KKR	= Kader Kesehatan Remaja
IEC	= Information, Education, Communication
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
BKR	= Bina Keluarga Remaja

CHAPTER 2

MENYUSUI: PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG IBU MENYUSUI

Eni Folendra Rosa, SKM., MPH.

A. Pendahuluan

Menyusui merupakan metode pemberian nutrisi terbaik bagi bayi, sesuai dengan rekomendasi WHO yang menyarankan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Menyusui tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi bayi, tetapi juga bagi ibu, seperti mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium. Namun, proses menyusui tidak selalu mudah bagi ibu. Tantangan seperti kurangnya dukungan, tekanan sosial, dan kelelahan fisik sering menjadi hambatan. Dalam konteks ini, peran keluarga menjadi krusial untuk membantu ibu menyusui melewati masa-masa sulit tersebut.

Menyusui adalah proses alami yang memberikan manfaat kesehatan bagi ibu dan bayi. Namun, ibu menyusui sering menghadapi tantangan fisik, emosional, dan sosial yang dapat mempengaruhi keberhasilan menyusui. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan biologis, psikologis, sosial dan spiritual kepada ibu menyusui. Dukungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang dapat membantu ibu merasa lebih percaya diri dan mampu menjalankan perannya sebagai ibu menyusui. Bab ini membahas pentingnya peran keluarga dalam mendukung ibu menyusui, bentuk-bentuk dukungan yang dapat diberikan, dan praktik terbaik untuk mendukung keberhasilan menyusui.

B. Peran Keluarga Bagi Ibu Menyusui

Peran aktif dan dukungan keluarga pada ibu menyusui akan memberikan rasa percaya diri, motivasi untuk mampu mengatasi tantangan menyusui dengan baik. Hal ini dapat berdampak positif pada keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan meningkatkan kesehatan ibu serta bayi. Adapun anggota keluarga yang sangat penting memberi dukungan dan berperan sesuai dengan porsi masing-masing anggota keluarga antara lain ayah atau suami dapat berperan membantu menenangkan bayi di malam hari agar ibu bisa beristirahat serta mendukung ibu secara emosional dengan memberikan perhatian dan semangat. Orang tua dan atau mertua berperan memberikan makanan tradisional yang dipercaya membantu

meningkatkan ASI, mengurangi tekanan pada ibu dengan tidak memaksakan pola pengasuhan tertentu, sedangkan anak yang lebih besar dapat berperan membantu mengurus hal kecil seperti mengambilkan perlengkapan bayi dan memberikan dukungan moral dengan memuji usaha ibu.

Dukungan suami memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi keberhasilan menyusui karena suami adalah orang yang paling dekat secara psikologis dan emosional dengan ibu dan bayi, selain itu juga suami berperan memastikan istri tak kelelahan, menciptakan suasana positif agar istri merasa nyaman, aman dan tidak stres. Bentuk dukungan seperti pemenuhan nutrisi ibu menyusui, dukungan saat ibu sudah kembali bekerja dan membantu melakukan ASI Perah, dan lainnya. Peran suami sebagai pendamping dan mitra tidak hanya berfokus pada dukungan psikologis dan emosional tetapi juga partisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari berupa dukungan fisik seperti mengganti popok, pemenuhan nutrisi ibu

Dukungan terhadap ibu menyusui selalu menjadi tema fokus intervensi pada setiap peringatan hari ASI sedunia. Pada tahun 2022 dengan tema *Set Up for Breastfeeding: Educate and Support*. UNICEF dan WHO terus mendukung pemerintah mengajak mitra dan anggota masyarakat untuk melindungi, mempromosikan dukungan terhadap praktik menyusui yang optimal, mendorong tindakan tegas terhadap pemasaran produk pengganti ASI yang salah dan merugikan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu memastikan dukungan ketersediaan layanan konseling menyusui bagi semua ibu dan pengasuh anak usia di bawah dua tahun, baik secara tatap muka maupun melalui platform digital.

Pada peringatan pekan menyusui sedunia, UNICEF dan WHO 2023 menghimbau agar tempat kerja menerapkan kebijakan yang lebih baik, sedangkan pada peringatan tahun 2024 UNICEF dan WHO dengan tema menyerukan peningkatan dukungan selama periode menyusui, terutama selama minggu pertama kehidupan seorang anak sejak dini serta dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif. Dukungan keluarga sangatlah berperan besar bagi ibu sebagai orang terdekat yang kebersamaan ibu lebih banyak dirumah.

Secara garis besar bentuk dukungan keluarga bagi ibu menyusui dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sebagai Pendukung Utama

Dalam hal ini keluarga berperan sebagai pendukung utama dalam memberikan dorongan moral, perhatian, dan kepedulian kepada ibu menyusui serta membantu ibu agar merasa tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan menyusui.

2. Sebagai Penyedia Sumber Daya

Keluarga berperan dalam memastikan ibu memiliki akses terhadap nutrisi yang cukup, sarana dan prasarana menyusui, serta lingkungan yang kondusif. Dukungan tenaga yang siap berada disamping ibu memenuhi kebutuhan dalam mendukung pemberian ASI.

3. Sebagai Penjaga Keseimbangan Emosi

Membantu ibu mengelola stres dan emosi melalui dukungan psikologis yang konsisten.

4. Sebagai Pemberi Informasi

Membantu ibu mendapatkan pengetahuan yang relevan tentang teknik menyusui yang benar dan pentingnya ASI eksklusif.

5. Sebagai Fasilitator Kesehatan

Mengantar ibu untuk mendapatkan bantuan konselor laktasi atau tenaga kesehatan jika diperlukan.

C. Dukungan Keluarga bagi Ibu Menyusui

1. Dukungan Instrumental (Tangible and Instrumental Support)

- a. Membantu pekerjaan rumah tangga, hal ini bertujuan agar ibu memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk menyusui.
- b. Menyediakan makanan bergizi sesuai dengan standar kecukupan pemenuhan nutrisi dan cairan bagi ibu menyusui sesuai dengan kondisi tahapan menyusui bayi 0-6 bulan, pemenuhan nutrisi pada ibu 7-12 bulan sampai dengan pemenuhan nutrisi ibu menyusui bayi diatas 1 sampai 2 tahun, Pemenuhan nutrisi dan cairan ini penting agar ibu dapat mempertahankan produksi ASI dan gizi ibu tercukupi sesuai dengan perkembangan bayi. Makanan harusnya mencukupi kebutuhan protein dan zat nutrisi lainnya seperti sup ikan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan untuk meningkatkan produksi ASI. Dukungan pemberian booster ASI jika diperlukan dan atau pemberian makanan dan sayuran yang dapat mendukung peningkatan produksi ASI
- c. Mengelola kebutuhan bayi dengan cara memberi dukungan pada ibu dalam mengurus keperluan bayi seperti mengganti popok atau menenangkan bayi saat ibu beristirahat.
- d. Membeli perlengkapan menyusui atau alat-alat yang ibu butuhkan selama menyusui, misalnya, bantal menyusui, pompa ASI, atau penyimpanan ASIP.

2. Dukungan Informasi (Informational Support)

- a. Mengedukasi keluarga tentang manfaat ASI bertujuan agar seluruh anggota keluarga memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif.

- b. Memberikan panduan menyusui, seperti posisi dan perlekatan bayi yang benar, bagaimana upaya mempertahankan produksi ASI serta bentuk informasi lainnya terkait tentang fisiologi menyusui.
- c. Menghubungkan ibu dengan ahli, terutama jika ibu mengalami permasalahan dalam menyusui dengan cara membantu dan memfasilitasi ibu untuk dapat berkonsultasi dengan konselor laktasi
- d. Menghindari mitos dengan mengarahkan ibu pada informasi yang benar dan ilmiah, misalnya tentang produksi ASI yang cukup atau pantangan-pantangan selama menyusui yang merugikan kesehatan ibu dan bayi dan berpotensi terjadinya kegagalan ibu dalam memberikan ASI eksklusif.

3. Dukungan Emosional (Emotional or Esteem Support)

- a. Menunjukkan empati dengan cara mendengarkan keluhan ibu tanpa menghakimi atau memberi tekanan.
- b. Memberikan semangat dan mengingatkan ibu bahwa menyusui artinya ibu sedang memberikan hal terbaik untuk bayinya.
- c. Mengurangi konflik dengan menciptakan suasana rumah yang tenang dan harmonis.
- d. Meningkatkan kepercayaan diri dengan memberikan afirmasi positif berupa kata-kata penguatan bagi ibu menyusui, seperti "Ibu telah melakukan hal luar biasa untuk bayi ibu."

4. Dukungan Penilaian (Appraisal Support)

- a. Memberikan pujian yaitu dengan memberikan apresiasi usaha ibu dalam menyusui, seperti "Hebat ya, kamu bisa menyusui eksklusif selama ini."
- b. Mengakui keberhasilan ibu dalam menyusui sekecil apapun yang sudah dilakukan ibu, misalnya saat ibu berhasil menyusui bayi secara eksklusif selama satu bulan pertama.
- c. Membandingkan secara positif dengan cara menceritakan pengalaman ibu menyusui lain yang sukses memberikan ASI eksklusif untuk memotivasi ibu agar sukses dalam menyusui.
- d. Mendorong ibu untuk tetap konsisten dengan cara mengingatkan ibu akan manfaat jangka panjang ASI untuk kesehatan bayi.

D. Dukungan Praktik Menyusui

Dukungan keluarga dalam praktik menyusui adalah segala bentuk bantuan, motivasi, dan pemahaman yang diberikan oleh anggota keluarga untuk membantu ibu menyusui menjalani proses menyusui dengan nyaman, lancar, dan sukses. Dukungan ini sangat penting karena menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi.

Perawatan payudara dan massage dapat dilakukan terhadap ibu menyusui dalam upaya mendukung keberhasilan menyusui. Tindakan tersebut dapat berupa *breast care*, massage oksitosin, massage oketani, massage woolwich , massage effleurage dan atau massage marmet. Massage tersebut selain dapat memberikan relaksasi bagi ibu menyusui, meningkatkan hormon bahagia juga dapat membantu mencegah atau mengatasi sumbatan ASI serta sebagai upaya meningkatkan dan mempertahankan produksi ASI. Adapun bentuk dukungan praktik menyusui antara lain:

1. Latihan Pernafasan

Mindfulness adalah bentuk dukungan keluarga dalam praktik menyusui yang sangat penting adalah membimbing ibu untuk melakukan latihan pernapasan atau meditasi agar lebih tenang. Suami membantu ibu melakukan latihan ini setiap malam sebelum tidur untuk mengurangi stres harian. Dukungan suami mulai dari menyiapkan ruangan yang tenang dan nyaman untuk latihan dan mendiskusikan pengalaman dan perasaan ibu selama latihan.

2. Hypnobreastfeeding

Salah satu pendekatan holistik yang dapat memberikan manfaat luar biasa bagi ibu dan bayi, merupakan teknik relaksasi membantu kelancaran proses menyusui dengan memperhatikan pikiran (*mind*), tubuh (*body*), dan jiwa (*soul*) ibu menyusui. Hypnobreastfeeding bermanfaat membantu ibu lebih rileks, tenang dan nyaman selama menyusui sehingga menjadi umpan balik yang positif yaitu peningkatan pelepasan oksitosin dan prolaktin, dengan bantuan panduan audio ibu dapat melakukan sendiri dirumah,

Hypnobreastfeeding membantu ibu menjadikan pengalaman menyusui yang lebih positif dan menyenangkan, melalui teknik relaksasi berbasis hipnosis yang dirancang untuk membantu ibu menyusui mengelola emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan hubungan dengan bayinya. Teknik ini melibatkan penggunaan afirmasi positif, visualisasi, dan latihan pernapasan untuk menciptakan pengalaman menyusui yang lebih tenang dan sukses.

Hypnobreastfeeding bermanfaat dalam membantu merangsang hormon prolaktin (produksi ASI) dan oksitosin (refleks let-down) dengan menciptakan suasana rileks, membantu ibu menyusui mengatasi stres atau kecemasan yang dapat menghambat aliran ASI, terutama bagi ibu baru atau mereka yang menghadapi tekanan menyusui. Melalui afirmasi positif dan visualisasi, hypnobreastfeeding membantu ibu merasa lebih percaya diri dengan kemampuan tubuh mereka untuk menyusui. Membantu ibu yang mengalami kesulitan menyusui, seperti rasa sakit, bayi yang sulit menyusu, atau masalah laktasi lainnya, dengan memberikan ketenangan dan motivasi.

Teknik hipnosis mendukung pelepasan oksitosin, yang sangat penting untuk refleksi let-down, sehingga ASI dapat keluar lebih mudah, menciptakan pengalaman yang lebih harmonis dan intim antara ibu dan bayi melalui fokus pada ikatan emosional. Menurunnya tingkat stres, ibu menyusui dapat merasa lebih sehat secara fisik dan emosional, yang berdampak positif pada kesehatan bayi. Teknik relaksasi ini juga membantu tubuh ibu pulih lebih cepat setelah melahirkan dengan meningkatkan sirkulasi darah dan keseimbangan hormon.

Ibu yang lebih rileks cenderung memiliki pola tidur yang lebih baik, meskipun memiliki jadwal menyusui yang sibuk dan juga merasakan ketenangan yang dihasilkan oleh ibu selama proses menyusui sehingga membantu menciptakan pola menyusui yang lebih baik.

3. SPEOS (Stimulation, Pressure, Expression, Optimization of Supply)

Salah satu teknik terapi yang bertujuan mengintegrasikan keseimbangan spiritual, emosional, dan fisik dalam kehidupan seseorang. Manfaat utama adalah membantu melepaskan emosi yang tersimpan atau tertekan, seperti trauma, rasa takut, kemarahan, atau kesedihan, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Terapi ini membantu individu mengelola emosi dengan lebih baik, menciptakan rasa tenang, damai, dan kontrol diri yang lebih baik.

SPEOS memungkinkan seseorang untuk terhubung lebih dalam dengan aspek spiritual dirinya, membantu menemukan tujuan hidup, dan memberikan rasa harmoni secara keseluruhan. Terapi SPEOS ini dapat mengurangi stres dan kecemasan yang sering kali terkait dengan pengalaman hidup atau tantangan sehari-hari. Emosi negatif dapat mempengaruhi kesehatan fisik, pelepasan emosi melalui stimulasi ini dapat membantu memperbaiki kondisi fisik seperti nyeri kronis, ketegangan otot, atau gangguan tidur, dengan emosi yang lebih stabil, individu dapat berkomunikasi lebih baik, memperbaiki hubungan interpersonal, dan menciptakan interaksi yang lebih sehat.

Teknik stimulasi ini juga sering digunakan untuk menangani trauma mendalam atau pengalaman yang sulit, memberikan ruang untuk penyembuhan dengan cara yang aman dan penuh perhatian. Terapi ini mendorong individu untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, sehingga mereka dapat berubah ke arah yang lebih positif dan memenuhi potensi diri dan biasanya dilakukan oleh terapis berpengalaman yang membantu klien melalui teknik relaksasi, meditasi, dan eksplorasi emosi mendalam.

4. Akupresur

Teknik tradisional Tiongkok melibatkan penekanan pada titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang aliran energi (Qi) dan meningkatkan kesehatan. Keluarga dapat meminta bantuan terapis akupresur yang bersertifikat agar terapi

dilakukan dengan aman dan efektif. Pada ibu menyusui, akupresur memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan fisik maupun emosional, antara lain membantu merangsang hormon prolaktin dan oksitosin, yang berperan penting dalam produksi dan pelepasan ASI.

Titik akupresur seperti Titik Tangzhong (CV17) di tengah dada dan Titik Sanyinjiao (SP6) di kaki sering digunakan untuk meningkatkan produksi ASI. Akupresur membantu mengurangi rasa sakit akibat pembengkakan payudara, saluran ASI yang tersumbat, atau mastitis. Teknik ini juga dapat meredakan ketegangan otot di area dada dengan menekan titik-titik tertentu yang dapat melancarkan aliran energi dan cairan, sehingga membantu mengatasi saluran ASI yang tersumbat.

Selain itu akupresur dapat merangsang relaksasi, mengurangi stres, dan membantu ibu merasa lebih tenang, hal ini penting karena stres dapat menghambat produksi ASI. Membantu meningkatkan energi tubuh ibu yang sering merasa lelah setelah melahirkan dan selama menyusui, sehingga mendukung pemulihan pasca melahirkan. Membantu memastikan payudara menerima suplai darah yang cukup untuk mendukung produksi ASI. membantu tubuh mengatur keseimbangan hormon untuk produksi ASI yang optimal dan menjaga suasana hati ibu menyusui.

Titik Akupresur yang umum untuk ibu menyusui adalah titik CV 17 (Tangzhong) yang terletak di tengah tulang dada, membantu merangsang aliran ASI. Titik SP6 (Sanyinjiao) terletak di bagian dalam kaki, sekitar 3 jari di atas pergelangan kaki, baik untuk keseimbangan hormon. Titik LI 4 (Hegu) terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk, berguna untuk relaksasi dan mengurangi rasa sakit, sedangkan titik ST 36 (Zusanli) terletak di bawah lutut, baik untuk meningkatkan energi dan mendukung pemulihan tubuh.

5. Breast Care

Suatu tindakan perawatan payudara terutama pada ibu nifas dan sebaiknya dilakukan pada saat sebelum mandi pagi dan mandi sore, yang bertujuan untuk merangsang sekresi hormon oksitosin untuk menghasilkan ASI sedini mungkin. Dilakukan dengan gerakan melingkar pada payudara untuk merangsang aliran darah dan limfa. Membantu melancarkan aliran ASI dan mengurangi rasa sakit atau pembengkakan.

Perawatan ini biasanya mencakup pijatan lembut, kompres, dan pemakaian produk perawatan khusus. Perawatan payudara bermanfaat membantu merangsang aliran darah ke jaringan payudara, sehingga mendukung produksi ASI yang optimal. Dengan pijatan yang tepat, breast care membantu membuka saluran ASI yang tersumbat, mengurangi resiko pembengkakan (engorgement)

dan mastitis. Pijatan lembut dapat meredakan nyeri akibat pembengkakan payudara atau posisi menyusui yang kurang tepat.

Breast Care mencakup pembersihan yang dapat membantu menjaga area payudara tetap bersih dan bebas dari infeksi, terutama di sekitar puting. Pijatan dan kompres hangat guna merangsang hormon oksitosin, yang membantu refleksi let-down saat menyusui. Breast Care juga membantu menjaga bentuk payudara agar tetap sehat dan kencang setelah menyusui. Perawatan ini memberikan efek relaksasi bagi ibu, membantu mengurangi stres yang dapat mempengaruhi produksi ASI serta dapat membantu mempercepat proses pemulihan jaringan payudara yang mengalami perubahan selama kehamilan dan menyusui

6. Massage oksitosin

Hormon oksitosin memainkan peran vital dalam mendukung keberhasilan menyusui dan dikenal sebagai "hormon cinta" karena perannya dalam merangsang refleksi let-down, yaitu pelepasan ASI dari kelenjar susu menuju saluran ASI, serta menciptakan rasa tenang dan bahagia pada ibu. Stres, kelelahan, dan tekanan sehari-hari seringkali menghambat produksi oksitosin, yang berujung pada kesulitan menyusui sehingga pijat oksitosin menjadi solusi yang efektif dan aman.

Pijat oksitosin dengan menstimulasi area tertentu pada punggung dan bahu ibu untuk merangsang produksi oksitosin, sehingga memperlancar aliran ASI dan meningkatkan kesejahteraan ibu secara keseluruhan. Praktik ini tidak hanya membantu mengatasi masalah teknis dalam menyusui, tetapi juga memberikan manfaat relaksasi mendalam. Pijat ini dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan suami sehingga menciptakan momen menyusui yang nyaman dan tenang.

7. Massage Oketani

Metode yang dipopulerkan Sotomi Oketani dari Jepang, bermanfaat menstimulasi kekuatan otot dada untuk meningkatkan produksi ASI dan membuat payudara menjadi lembut dan elastis sehingga memudahkan bayi untuk menghisap ASI serta mendukung kenyamanan serta optimalisasi produksi ASI. Metode ini berfokus pada stimulasi lembut jaringan payudara dan area di sekitarnya untuk meningkatkan aliran ASI, mengurangi nyeri, dan melepaskan ketegangan yang dapat menghambat proses menyusui.

Massage oketani bertujuan untuk merilekskan otot-otot di sekitar payudara dan meningkatkan aliran darah, yang pada akhirnya membantu ibu memproduksi dan melepaskan ASI dengan lebih baik. Teknik ini dilaporkan memberikan peningkatan yang signifikan dalam kenyamanan selama menyusui dan

kemampuan untuk menyediakan ASI lebih efektif. Manfaat utama pijat Oketani membantu memperbaiki aliran darah dan limfe di sekitar payudara meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi ASI, membantu mengatasi saluran ASI yang tersumbat, mastitis atau peradangan payudara, rasa nyeri akibat ASI yang tidak lancar serta memberikan efek relaksasi bagi ibu, membantu mengurangi stres yang menjadi penyebab masalah laktasi.

8. Massage Marmet

Pijat Marmet adalah salah satu tindakan membantu ibu mengosongkan payudara secara efektif, terutama saat memerah ASI secara manual. Teknik ini sering digunakan untuk meningkatkan produksi ASI dan mengatasi masalah menyusui. Manfaat dari pijat ini membantu merangsang aliran ASI dan memaksimalkan pengosongan payudara, sehingga menjaga produksi ASI. Dengan mengosongkan payudara secara menyeluruh, memberikan sinyal kepada tubuh untuk memproduksi lebih banyak ASI, sehingga membantu ibu yang memiliki masalah dengan pasokan ASI. Selain itu teknik ini membantu melancarkan saluran ASI yang tersumbat dan mengurangi risiko pembengkakan payudara (engorgement) atau mastitis.

Pijat Marmet efektif bagi ibu yang merasa kurang nyaman menggunakan pompa ASI atau yang tidak dapat menggunakan pompa karena alasan tertentu, membantu mengurangi ketegangan dan nyeri pada payudara, memberikan efek relaksasi, membantu ibu merasa lebih nyaman selama proses menyusui atau memerah ASI. Teknik pijat ini memastikan dapat mengeluarkan ASI akhir (hindmilk) yang lebih kaya lemak dan penting untuk pertumbuhan bayi. Stimulasi pijatan lembut di sekitar payudara menggunakan ujung jari dengan gerakan melingkar untuk merangsang aliran ASI dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk menekan jaringan payudara secara perlahan, mendorong ASI keluar ke arah puting. Pijat Marmet sangat direkomendasikan untuk ibu menyusui yang ingin mengoptimalkan pengosongan payudara secara alami.

9. Massage effleurage

Teknik pijat sederhana yang aman dan efektif membantu ibu merasa lebih nyaman dan mendukung kelancaran menyusui, dilakukan selama 5–10 menit sebelum menyusui atau memerah ASI untuk membantu memperlancar aliran ASI.

Teknik ini dengan pijatan ringan gerakan meluncur di kulit untuk memberikan rasa relaksasi dan meningkatkan aliran darah.

Manfaat pijat ini dapat mendukung kesehatan fisik dan emosional, membantu merangsang hormon oksitosin, yang berperan dalam refleksi let-down, sehingga memudahkan keluarnya ASI, membantu memperbaiki sirkulasi darah dan limfe di sekitar payudara, yang penting untuk memastikan saluran ASI

tetap lancar, membantu meredakan rasa sakit akibat pembengkakan payudara atau ketegangan otot di area dada. Membantu membuka saluran ASI yang tersumbat dan mencegah mastitis, memberikan efek menenangkan, membantu ibu merasa lebih rileks, membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, yang mempercepat proses pemulihan setelah melahirkan.

Efek pijatan yang menenangkan membantu ibu mengatasi stres atau kelelahan yang sering dialami selama masa menyusui serta dapat meredakan ketegangan pada otot punggung, leher, dan bahu yang sering terjadi karena posisi menyusui yang tidak ergonomis. Massage Woolwich

Manfaat pijat ini meningkatkan aliran darah ke payudara, yang membantu merangsang refleks let-down dan memastikan ASI mengalir lebih lancar, membantu membuka saluran ASI yang tersumbat, mencegah pembengkakan serta mengurangi rasa nyeri. Pijat ini memberikan bantuan untuk mengurangi nyeri yang disebabkan oleh pembengkakan payudara atau ketegangan otot di sekitar dada, merangsang hormon oksitosin dan prolaktin, membantu tubuh memproduksi lebih banyak ASI. Selain itu pijat ini membantu ibu untuk pulih lebih cepat dengan meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat proses penyembuhan, membantu lebih rileks dan tenang dan kesejahteraan emosional dengan meningkatnya aliran darah dan merangsang sistem limfatik.

Pijat dilakukan dengan gerakan lembut pada payudara dan area sekitarnya dengan tekanan lembut merangsang aliran darah tanpa menyebabkan ketidaknyamanan dan untuk hasil yang optimal sering dikombinasikan dengan teknik lain seperti pijat oksitosin atau pijat marmet.

E. Simpulan

Keluarga memiliki peran sentral dalam mendukung keberhasilan ibu menyusui, dukungan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Dukungan hendaknya diberikan secara holistik agar ibu menyusui dapat merasa lebih percaya diri dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi selama menjalankan peran selama proses menyusui, karena sejatinya dukungan secara holistik meliputi dukungan fisik, psikologis, sosial dan spiritual guna meningkatkan pemahaman yang utuh tentang menyusui serta praktik menyusui yang optimal. Melalui kerjasama keluarga, menyusui dapat menjadi pengalaman yang positif dan bermakna bagi ibu dan bayi.

F. Referensi

- American Psychological Association. (2023). *Mindfulness and Meditation in Daily Life*. Washington, DC: APA.
- Arsi, R., Afdhal, F., & Saputra, A. U. (2023). Pengaruh metode SPEOS (Stimulasi Pijat Endorfin, Oksitosin, dan Sugestif) dan murottal Al-Qur'an terhadap produksi ASI ibu post sectio caesarea. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 18(2), 88–98.
- Farhadi, R. (2020). Spiritual aspects of breastfeeding: A narrative review. *Journal of Pediatrics Review*, 8(4), 229–236. <https://doi.org/10.32598/jpr.8.4.47.3>
- Franciska, Y., & Yuka, A. A. S. (2023). The effect of hypnobreastfeeding and lactation massage on breast milk production. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan*, 10(2), 174–185.
- Inoue, C., Hashimoto, Y., Nakatani, Y., & Ohira, M. (2022). Smartphone use during breastfeeding and its impact on mother-infant interaction and maternal responsiveness: Within-subject design. *Nursing & Health Sciences*, 24(1), 224–235. <https://doi.org/10.1111/nhs.12918>
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full Catastrophe Living*. New York: Bantam Books.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pemberian ASI Eksklusif*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2021). *Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession*. Elsevier.
- Riordan, J., & Wambach, K. (2020). *Breastfeeding and Human Lactation*. Jones & Bartlett Learning.
- Rosa, E. F. (2022). Konseling menyusui berbasis android terhadap keberhasilan ASI eksklusif di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2), 659–668. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i2.3145>
- Rosa, E. F. (2023). *Edukasi Holistik Menyusui, Sukseskan ASI Eksklusif*. Yogyakarta: Deepublish. ISBN: 978-623-02-5966-1
- Rosa, E. F., & Aisyah, M. E. (2024). Edukasi teknik menyusui pada ibu dengan defisit pengetahuan perlekatan menyusui: Studi kasus. *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya*, 10(1), 40–45.
- Rosa, E. F., Pome, G., & Rustiati, N. (2023). Edukasi massage oksitosin pada ibu menyusui dengan masalah menyusui tidak efektif. *Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Maarif Baturaja*, 8(2), 189–197.
- Rosa, E. F., Rohana, I. G. A. P. D., & Ulfa, M. H. (2022). Effectiveness of exclusive breastfeeding holistic education. *Rawal Medical Journal*, 47(4), 1026–1026.
- Rosa, E. F., Wahyuni, S & Ulfa, M. H. (2024). *BEST FOR MOMS: Sukses Menyusui Tanpa Drama*. Yogyakarta: Deepublish. ISBN: 978-634-200-201-8
- Rosa, E.F, Suryanda., Rustiati N., Salsabilah D. (2023). Efektivitas teknik hypnobreastfeeding dalam mendukung ASI eksklusif. *Jurnal Obsgins: Jurnal*

Ilmiah Ilmu Kebidanan dan Kandungan, 14(2), 321-329.
<https://doi.org/10.36089/job.v15i2.1200>

Roy, S. K., Tasnim, S., Jahan, M. K., Nazmeen, S., Debnath, S. C., & Islam, A. B. M. M. (2019). Difficulties in breastfeeding: Easy solution by Oketani breast massage. *Bangladesh Medical Research Council Bulletin*, 45(3), 149–154.
<https://doi.org/10.3329/bmrcb.v45i3.44644>

UNICEF Indonesia. (2023). *Dukungan Keluarga dalam Menyusui*. Jakarta: UNICEF.

Walter, M. H., Abele, H., & Plappert, C. F. (2021). The role of oxytocin and the effect of stress during childbirth: Neurobiological basics and implications for mother and child. *Frontiers in Endocrinology*, 12, 742236.
<https://doi.org/10.3389/fendo.2021.742236>

World Health Organization. (2023). *Breastfeeding Recommendations*. Geneva: WHO.

CHAPTER 3

MENDUKUNG KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN: PERAN KELUARGA DALAM PERAWATAN PUERPERIUM

Ns. Anita Rahmawati, M.Kep.

A. Pendahuluan

Masa pasca melahirkan atau puerperium merupakan salah satu fase penting bagi perempuan dalam siklus reproduksinya. Pada masa pasca melahirkan terjadi perubahan atau adaptasi baik fisik maupun psikologis. Selama fase ini, organ panggul Kembali ke keadaan sebelum hamil, perubahan metabolik selama kehamilan juga kembali dan dimulainya proses laktasi. Ibu pasca melahirkan rentan mengalami berbagai masalah kesehatan sehingga membutuhkan perawatan agar pemulihan optimal dan tidak menimbulkan komplikasi seperti infeksi, perdarahan, eklamsi bahkan kematian (Aisien, 2021; Sendas & Freitas, 2024). Perawatan yang kurang tepat pada masa puerperium dapat meningkatkan resiko terjadinya masalah yang tidak hanya berdampak bagi kesehatan ibu tetapi juga bagi kesehatan bayi. Puerperium merupakan masa yang krusial untuk membentuk ikatan emosional antara bayi, ibu dan anggota keluarga yang lain sehingga penyesuaian diri dengan peran baru yaitu peran sebagai orang tua sangat dibutuhkan dalam fase pasca melahirkan. Kesulitan dalam perawatan bayi baru lahir, laktasi, kelelahan, kecemasan dan depresi postpartum dapat memperberat kondisi kesehatan ibu postpartum (Finlayson et al., 2020).

Kondisi kesehatan yang buruk pada ibu postpartum beresiko menyebabkan kematian. Angka kematian/morbiditas ibu yang berkaitan dengan proses kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran diperkirakan 303.000 setiap tahunnya dan mayoritas penyebab kematian terjadi pada masa puerperium. Sedangkan kematian neonatus (kematian dalam 28 hari pertama setelah kelahiran) hampir tiga juta setiap tahunnya (Finlayson et al., 2020). Kematian ibu postpartum dan neonatus dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti komplikasi selama kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran dengan 3 faktor utamanya yaitu hemoraghi pasca partum (HPP), infeksi/sepsis dan preeklamsi/eklamsi. faktor lain yang juga mempengaruhi secara tidak langsung seperti status sosial dan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan maternal, budaya, kebijakan kesehatan, dan elemen lingkungan (Putu et al., 2024).

Elemen lingkungan dapat berupa *support system* atau dukungan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu pada masa puerperium. Dukungan sosial dari keluarga dapat memberikan dampak positif bagi kondisi psikososial. Dukungan sosial mengacu pada ketersediaan orang lain untuk menyediakan sumber daya emosional, psikologis dan material yang berfungsi sebagai sumber daya dalam penanggulangan dampak kesehatan pada masa puerperium. Dukungan sosial dari keluarga juga menjadi faktor pelindung terhadap stress, kecemasan, depresi dan gangguan mental lain yang resiko muncul pada ibu postpartum dan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup (Khademi & Kaveh, 2024). Sejumlah temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang baik dengan anggota keluarga memberikan peran penting dalam menanggulangi depresi postpartum dan meningkatkan kualitas tidur (Qi et al., 2022).

B. Masa Puerperium

Periode postpartum atau puerperium, adalah masa setelah persalinan ketika tubuh ibu mengalami perubahan fisiologis dan anatomis untuk kembali ke kondisi tidak hamil. Postpartum terbagi menjadi tiga fase utama dengan durasi yang bervariasi. Fase akut atau *immediate postpartum* yang berlangsung selama 24 jam pertama setelah plasenta lahir, fase awal atau *early postpartum* yang berlangsung hingga 7 hari, fase akhir atau *late postpartum* yang dapat berlangsung antara 6 minggu hingga 6 bulan. Setiap fase memiliki tantangan dan pertimbangan klinis yang berbeda. Selain mengalami perubahan pada dimensi fisiologis, pada masa puerperium juga terjadi perubahan pada dimensi psikologis yang dapat mengurangi kualitas hidup (Govahi et al., 2024).

Periode postpartum dimulai setelah keluarnya plasenta dan berlangsung hingga pemulihan penuh dari berbagai sistem organ, sehingga pada periode ini terjadi perubahan atau proses adaptasi dari seluruh sistem organ tubuh meliputi perubahan sistem reproduksi, perubahan payudara, perubahan sistem hormonal atau endokrin dan sistem pencernaan. Selain itu, terdapat perubahan pada sistem muskuloskeletal, tanda-tanda vital, serta sistem kardiovaskular dan peredaran darah. Perubahan lainnya meliputi sistem hematologi, pernapasan, integumen (kulit), keseimbangan cairan dan elektrolit, serta penurunan berat badan. Selama masa nifas, ibu mengalami berbagai perubahan anatomi dan fisiologis. Pada sistem reproduksi terutama uterus mengalami proses involusi dengan mengecilnya ukuran uterus secara bertahap sehingga tinggi fundus semakin menurun dan pada hari kesembilan pasca persalinan uterus sudah tidak teraba. Jika proses ini terganggu akan terjadi sub involusi yaitu kegagalan uterus untuk kembali ke keadaan sebelum

hamil. Penyebab sub involusi yang sering adalah fragmen plasenta yang tertahan dan infeksi (Luo et al., 2021).

Pada masa puerperium dimulainya proses laktasi dimana proses ini mengharuskan payudara berubah dalam komposisi, ukuran, dan bentuk selama setiap tahap perkembangan wanita. Pada masa laktasi, payudara mengalami perubahan yaitu lapisan paling atas terdiri dari sel skuamosa berkeratin yang secara tiba-tiba berubah menjadi epitel berlapis ganda, yaitu lapisan luminal dan mioepitel, yang merupakan bagian dari sisa sistem duktus dan lobulus. Duktus besar kemudian bermuara ke unit lobular duktus terminal, yang selanjutnya bercabang menjadi kelompok asinus kecil menyerupai buah anggur untuk membentuk lobulus. Terdapat tiga jenis lobulus, yakni tipe 1, 2, dan 3, yang berkembang pada tahap berbeda dalam pertumbuhan wanita. Jumlah dan ukuran lobulus meningkat secara bertahap, dan menjelang akhir kehamilan, payudara hampir sepenuhnya terdiri dari lobulus yang dipisahkan oleh sedikit stroma. Payudara baru mencapai kematangan penuh dan berfungsi optimal setelah akhir kehamilan (Sampieri & Montero, 2019).

Perubahan pada sistem pencernaan menyebabkan ibu berisiko mengalami konstipasi dikarenakan dehidrasi, usus besar tertekan selama kehamilan, kurang intake cairan, hemorroid, robekan jalan lahir. Anoreksia juga dapat terjadi akibat penurunan sekresi kelenjar pencernaan. Minggu pertama pasca persalinan menunjukkan hilangnya cairan ekstraseluler. Setelah melahirkan, ibu biasanya mengalami penurunan berat badan sekitar 5-6 kg, yang berasal dari bayi, plasenta, air ketuban, serta darah yang keluar selama persalinan. Selain itu, tubuh juga mengeluarkan sekitar 2-3 kg melalui urine sebagai cara mengurangi cairan yang tertimbun selama kehamilan. Umumnya, ibu akan kembali ke berat badan ideal dalam waktu sekitar 6 bulan, meskipun sebagian besar tetap memiliki berat badan yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, dengan rata-rata tambahan sekitar 1,4 kg. Kenaikan berat badan selama kehamilan yang melebihi rekomendasi yang berlaku bagi wanita dengan obesitas secara signifikan meningkatkan risiko tertahannya berat badan tersebut hingga satu tahun setelah persalinan (Vesco et al., 2009).

Perubahan fisiologis terjadi cukup mencolok meskipun dianggap wajar, di mana proses yang terjadi selama kehamilan berangsur-angsur berbalik. Respon ibu terhadap bayinya pada periode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat energi, rasa nyaman, kondisi kesehatan bayi baru lahir, serta dukungan dan perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan termasuk juga dukungan dari pasangan atau keluarga. Selain perubahan fisiologis, pada masa nifas akan diikuti oleh perubahan psikologis dan emosi ibu. Bagi mereka yang belum memahami hal ini, perubahan yang terjadi bisa menimbulkan kekhawatiran. Oleh karena itu,

penting bagi ibu untuk mengenali dan memahami perubahan tersebut agar mampu mengidentifikasi serta mengatasinya sejak dini. (Ritonga et al., 2022).

C. Pola Hidup Sehat di Masa Puerperium

Pola hidup sehat adalah kebiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik maupun mental secara keseluruhan. Pola hidup sehat selama masa puerperium sangat penting untuk diterapkan karena dengan pola hidup sehat dapat membantu ibu postpartum lebih cepat dalam proses pemulihan dan menjaga kesejahteraan fisik maupun mental. Beberapa aspek pola hidup sehat yang harus diperhatikan pada masa puerperium yaitu:

1. Nutrisi

Nutrisi yang baik pada masa puerperium sangat dibutuhkan salah satunya untuk mempercepat penyembuhan luka dan pemulihan kondisi sehingga ibu dapat segera beraktivitas sehari-hari secara mandiri. Dampak yang akan muncul jika ibu postpartum kekurangan nutrisi diantaranya proses penyembuhan luka lebih lama, meningkatkan resiko infeksi dan terganggunya proses laktasi. Hasil penelitian menunjukkan semua ibu postpartum dengan asupan nutrisi yang baik mempunyai proses penyembuhan luka perineum yang baik juga sedangkan ibu dengan nutrisi kurang, 82 % proses penyembuhan lukanya dalam kategori sedang dan 6,7 % dalam kategori buruk (Frilasari et al., 2020).

Asupan nutrisi yang baik pada ibu postpartum juga dibutuhkan untuk proses laktasi yang optimal. Air susu ibu (ASI) merupakan nutrisi terbaik yang paling ideal untuk bayi, ASI secara alami dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang lahir cukup bulan selama 4 hingga 6 bulan pertama kehidupannya. ASI menyediakan semua nutrisi penting dan molekul bioaktif yang dibutuhkan untuk kesehatan dan perkembangan bayi yang optimal. Pemberian ASI juga dikaitkan dengan berbagai hasil kesehatan yang positif dan penurunan risiko terkena penyakit kronis di masa depan. Asupan nutrisi ibu saat menyusui sangat penting untuk diperhatikan karena komposisi ASI sangat dipengaruhi oleh pola makan ibu selama menyusui serta cadangan lemak dalam tubuhnya dimana kedua faktor tersebut berperan penting dalam menentukan kualitas, kuantitas, dan kandungan nutrisi ASI (Marshall et al., 2022).

Pola makan ibu yang baik tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang dikonsumsi tetapi juga kecukupan kandungan makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien meliputi kandungan karbohidrat, protein, lemak dan cairan. Mikronutrien penting yang direkomendasikan untuk ibu menyusui meliputi vitamin A, vitamin D, folat, vitamin B1, vitamin B6, kalsium, seng, kalium, dan selenium. Vitamin B kompleks dalam ASI menjadi sumber utama bagi bayi dan

dipengaruhi oleh pola makan ibu. Penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara asupan DHA ibu dengan komposisi ASI. Sebanyak 27 studi observasional dan 7 studi intervensi mengungkap bahwa konsumsi ikan serta asam lemak tak jenuh rantai panjang oleh ibu menyusui memiliki hubungan positif dengan kadar DHA dan EPA yang terkandung di dalam ASI (Petersohn et al., 2023).

Rekomendasi asupan makanan selama masa puerperium dan laktasi (Perichart-Perera, 2025):

a. Kebutuhan kalori

National Academy of Sciences (USA) merekomendasikan tambahan 404 kkal/hari untuk wanita postpartum dan menyusui sedangkan *The European Food Safety Authority* (EFSA) menetapkan kebutuhan energi rata-rata tambahan sebesar 500 kkal/hari.

b. Kebutuhan Protein

Peningkatan asupan protein 21-23 g/hari direkomendasikan pada ibu postpartum sampai 6 bulan pertama. Pada masa puerperium protein sangat penting untuk meningkatkan konservasi otot rangka, pembentukan sel baru untuk penyembuhan luka dan mempertahankan produksi ASI.

c. Kebutuhan lemak

Tidak ada rekomendasi khusus asupan lemak pada masa puerperium namun seperti kebutuhan pada orang dewasa setidaknya 20-35% dari total kalori. Asupan lemak yang penting adalah asam lemak omega-3 dan DHA. Asam lemak omega-3 merupakan precursor eikosanoid anti-inflamasi. Suplemen omega-3 menurunkan risiko depresi pasca persalinan.

d. Kebutuhan karbohidrat

Asupan karbohidrat minimal 210 g/hari dan asupan serat 29 g/hari. Jumlah dan jenis karbohidrat perlu diperhatikan dengan memilih jenis karbohidrat sehat yaitu makanan serat tinggi dan indeks glikemik rendah.

e. Kebutuhan vitamin

Konsumsi mikronutrien yang cukup pada ibu memiliki peran penting dalam mendukung berbagai fungsi tubuh, seperti proses metabolisme, pengangkutan oksigen, pembentukan DNA, perlindungan antioksidan, serta mendukung proses anabolik.

2. Kebersihan diri/*Personal Hygiene*

Personal hygiene atau kebersihan diri ibu postpartum dapat mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan rasa nyaman. Menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian, sprei dan lingkungan tempat tinggal. Tujuan menjaga kebersihan pada ibu nifas adalah untuk memenuhi kebutuhan

dasar dan mencegah risiko infeksi pascapersalinan. Menjaga kebersihan diri tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap infeksi, tetapi juga merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental ibu. (Magdalena Agu Yosali et al., 2021).

3. Aktivitas dan Istirahat

Aktivitas fisik pada masa puerperium berguna untuk mempercepat pemulihan kondisi kesehatan pada ibu postpartum. Hasil systematic review dari 12 studi menyimpulkan bahwa aktivitas fisik pada masa postpartum meningkatkan kualitas tidur ibu postpartum (Jones et al., 2025). Meskipun aktivitas fisik bermanfaat pada masa puerperium, penting untuk selalu memperhatikan pilihan durasi dan jenis aktivitas fisik yang sesuai di setiap periode postpartum. Jenis aktivitas sedang dan berat dalam jumlah besar selama periode pemulihan justru dapat mengganggu regenerasi jaringan yang rusak. aktivitas fisik ringan seperti peregangan dan berjalan atau melakukan senam nifas dapat meningkatkan sirkulasi darah (Wolpern et al., 2021).

Kelelahan sering terjadi pada ibu postpartum karena selain kondisi fisik dan psikologis yang masih dalam tahap adaptasi atau pemulihan, seorang ibu postpartum juga seringkali diberikan tanggungjawab penuh untuk merawat bayinya ditambah lagi tugas menyusui bayi bahkan terkadang masih dituntut untuk menyiapkan kebutuhan keluarga sehari-hari. Keseimbangan antara aktivitas dan istirahat harus diatur dengan baik, penelitian menunjukkan bahwa mengabaikan kebutuhan ini dapat berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan ibu tetapi juga pada kesehatan keluarga. Kurang tidur pada ibu postpartum dapat meningkatkan resiko depresi postpartum yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan resiko depresi ayah. Tidak berhenti disini tetapi dampak selanjutnya dapat meningkatkan risiko anak-anaknya mengalami masalah perilaku (Lambermon et al., 2020).

4. Dukungan sosial/emosional

Masa puerperium terutama pada periode awal postpartum merupakan periode kritis bagi orangtua yang baru pertama kali memiliki anak karena masih dalam tahap adaptasi dengan peran baru tersebut. Kurangnya dukungan sosial yang dirasakan keluarga terutama ibu merupakan faktor risiko munculnya masalah kesehatan mental. Komplikasi kesehatan mental terkait persalinan dapat mempengaruhi seluruh anggota keluarga terutama orangtua dan bayi baru lahir misalnya kesulitan dalam membangun bonding ibu dan bayi sehingga mengganggu proses menyusui, gangguan tidur, gangguan perkembangan anak, dan kesulitan dalam hubungan pasangan.

Dukungan sosial merupakan pertukaran sumber daya atau aktivitas timbal balik memberi dan menerima minimal antara dua individu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan orang yang menerima dukungan. Dukungan emosional merupakan dukungan yang diberikan untuk menguatkan emosi positif dan membantu mengatasi masalah atau emosi negatif. Dukungan emosional ditujukan untuk memberikan perasaan nyaman, perasaan dicintai dalam bentuk semangat dan empati. Sumber dukungan dapat formal dari penyedia layanan kesehatan dan informal dari teman atau keluarga. Dukungan menurunkan risiko stres pada orangtua dan kecemasan atau depresi pasca persalinan. Pemberian dukungan dapat meningkatkan efikasi diri orang tua dan rasa aman. Kurangnya dukungan pada periode pasca persalinan memberikan risiko munculnya emosi negatif dan tekanan psikologis orangtua. Kebutuhan dukungan ayah dan ibu berbeda, ibu membutuhkan lebih banyak dukungan emosional daripada ayah sedangkan ayah biasanya melihat dirinya sebagai pendukung utama bagi pasangan mereka. Selain itu, ayah juga ingin berperan aktif dalam merawat bayi yang baru lahir (Schobinger et al., 2022).

5. Pemeriksaan kesehatan rutin

Pemeriksaan rutin pada masa puerperium memberikan banyak manfaat untuk mendukung proses pemulihan kesehatan ibu dan perkembangan bayi baru lahir. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan neonates selama masa puerperium, jika faktor-faktor tersebut tidak dikendalikan dengan baik dapat menghambat proses pemulihan ibu dan mengganggu kesehatan neonatus. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin ibu dan bayi selama periode postpartum.

Adapun manfaat pemeriksaan rutin pada masa postpartum adalah sebagai berikut:

- a. Dapat sebagai media untuk deteksi dini komplikasi postpartum seperti tanda-tanda infeksi puerperalis, perdarahan postpartum, depresi postpartum dan gangguan kesehatan lain yang mungkin muncul pada masa postpartum.
- b. mengevaluasi proses pemulihan tubuh ibu seperti proses penyembuhan luka, involusi uterus dan adaptasi sistem organ tubuh yang lain.
- c. Dapat menjadi media untuk edukasi kesehatan terkait perawatan postpartum dan konseling menyusui
- d. Untuk skrining terhadap munculnya gejala depresi postpartum sehingga dapat dicegah secara dini

The American College of Obstetricians and Gynecologists merekomendasikan pemeriksaan rutin postpartum idealnya dilakukan minimal dalam 3 minggu pertama pasca persalinan dan penilaian awal

ini harus ditindaklanjuti dengan perawatan berkelanjutan sesuai kebutuhan dengan kunjungan pasca persalinan komprehensif paling lambat 12 minggu setelah melahirkan. Pemeriksaan atau kunjungan pasca persalinan komprehensif harus mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik, sosial dan psikologis (Stuebe et al., 2016). Periode pascapersalinan, yang mencakup 12 minggu setelah melahirkan, merupakan masa krusial bagi ibu baru dan keluarganya, sering disebut sebagai trimester keempat. Perawatan pascapersalinan dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui telepon, dan dapat melibatkan beberapa kali kunjungan untuk memastikan kebutuhan ibu terpenuhi secara menyeluruh. Pada awal masa pascapersalinan, perhatian utama harus diberikan pada kebutuhan mendesak serta risiko morbiditas dan mortalitas, kemudian beralih ke penanganan kondisi kronis dan upaya menjaga kesehatan. Komplikasi kehamilan, seperti gangguan hipertensi dan diabetes gestasional, berpengaruh pada kesehatan jangka panjang ibu sehingga memerlukan pemantauan khusus. Setiap ibu juga perlu menjalani evaluasi biopsikososial, seperti skrining depresi dan kekerasan pasangan intim, selama masa pascapersalinan. Selain itu, konseling pencegahan harus diberikan kepada ibu yang berisiko tinggi (Paladine et al., 2019).

D. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Puerperium

Komplikasi postpartum merupakan gangguan kesehatan yang dapat dialami ibu selama masa nifas. Komplikasi ini berpotensi menjadi penyebab utama kematian ibu, di mana periode nifas mencatat angka kematian tertinggi, yaitu sekitar setengah dari total kasus kematian ibu. Sementara itu, sekitar seperempat kematian terjadi pada masa kehamilan (antenatal) dan seperempat lainnya pada periode perinatal. Penyakit yang berpotensi mengancam jiwa pada masa postpartum umumnya mencakup perdarahan hebat segera setelah persalinan, komplikasi hipertensi, dan infeksi seperti endometriitis pada awal masa pascanatal. Selain itu, trombosis atau emboli, serta komplikasi dari penyakit yang sudah diderita sebelumnya, seperti penyakit jantung, juga dapat membahayakan nyawa selama masa nifas. Sementara itu, kondisi yang cenderung tidak mengancam jiwa meliputi infeksi lainnya seperti infeksi saluran kemih, mastitis, infeksi pada luka, gangguan menyusui, inkontinensia, dan disfungsi dasar panggul (Schrey-Petersen et al., 2021). Beberapa komplikasi postpartum yang umum terjadi diantaranya:

1. Perdarahan postpartum/*Postpartum Hemorrhage* (PPH)

HPP menjadi komplikasi postpartum dengan tingkat morbiditas dan mortalitas tertinggi dibanding jenis komplikasi yang lain. Faktor risiko dari perdarahan postpartum dibagi dalam 4 kategori yaitu (McLintock, 2020):

- a. Atonia uteri : kondisi yang dapat menyebabkan atonia uteri diantaranya pernah mengalami perdarahan postpartum sebelumnya, proses persalinan lebih dari 12 jam, induksi persalinan, kelahiran kala 3 yang memanjang, berat badan bayi lebih dari 4 kg, kehamilan kembar, peningkatan indeks massa tubuh (IMT) ibu yang berlebihan, dan infeksi
- b. Trauma saluran genital: kondisi yang dapat memicu trauma saluran genital yaitu instrumen/alat yang digunakan saat persalinan, dan ruptur uteri
- c. Masalah plasenta seperti retensi plasenta atau ada sisa plasenta yang tertinggal, abruptio/solotio plasenta (plasenta lepas dari dinding uterus sebelum waktunya baik sebagian ataupun keseluruhan), plasenta previa (plasenta menempel pada tempat yang tidak seharusnya sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir), plasenta accreta yaitu kondisi dimana plasenta menempel lebih dalam pada lapisan myometrium dinding uterus.
- d. Coagulopathy atau gangguan pembekuan darah biasanya pada emboli cairan amnion, sepsis, tranfusi yang masif dan *acute fatty liver* pada kehamilan
- e. Kecenderungan perdarahan bawaan dan menerima terapi antikoagulan

Pencegahan PPH dapat diawali dengan pemeriksaan dini faktor risiko sejak masa kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran. Mengenali gejala awal perdarahan postpartum penting dimengerti oleh ibu dan keluarga. Penanganan PPH disesuaikan dengan penyebabnya dan penanganan yang cepat dapat menurunkan risiko kematian.

2. Infeksi (Sepsis, endometritis, mastitis)

Infeksi puerperalis merupakan istilah untuk kejadian infeksi bakteri pada saluran reproduksi saat masa puerperium. Banyak faktor yang dapat memicu infeksi pada ibu postpartum. Hasil *systematic review* dari 3227 studi menunjukkan Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap infeksi pascapersalinan meliputi usia ibu, tingkat pendidikan, metode persalinan, serta tindakan episiotomi. Selain itu, anemia akibat perdarahan postpartum, intervensi dan manipulasi selama persalinan, kebersihan prenatal, penggunaan Povidone Iodine untuk membersihkan vagina sebelum persalinan, pemberian antibiotik sebagai tindakan pencegahan, durasi persalinan yang lebih lama, obesitas, dan keberadaan bakteri juga merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan risiko infeksi pascapersalinan. Kejadian infeksi puerperalis sekitar 5-7 % dan sepsis merupakan salah satu dari lima penyebab kematian pada masa postpartum yaitu sekitar 10 – 15 %. Risiko infeksi meningkat karena peningkatan resistensi antibiotik yang sangat cepat. Infeksi pada ibu postpartum dapat meningkatkan kecemasan dan berisiko terjadi depresi postpartum. Selain itu juga mengganggu proses bonding

dengan bayi yang akhirnya mengganggu proses laktasi (Boushra & Rahman, 2023).

Ketidakefektifan proses laktasi berisiko menyebabkan mastitis. Mastitis laktasi merupakan kondisi peradangan pada jaringan payudara yang biasanya terjadi pada ibu menyusui. Kondisi ini ditandai dengan demam tinggi dan gejala menyerupai flu, seperti nyeri tubuh dan menggigil. Selain itu, area payudara yang terkena cenderung mengalami kemerahan, rasa nyeri, panas, serta pembengkakan. Faktor penyebab mastitis diantaranya faktor yang berhubungan dengan anatomi dan proses menyusui, kerusakan puting merupakan faktor penyebab mastitis yang paling sering. Cedera pada puting sering terjadi pada ibu menyusui selama masa awal pasca persalinan dan dapat berupa retakan, kekeringan berlebih, atau luka pada area tersebut. Penyebab mastitis lainnya seperti kesalahan teknik menyusui, pembengkakan, tidak rutin menyusui, ketidaktenangan psikologis ibu sehingga menghambat oksitosin dan pengeluaran ASI. Mastitis juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial demografi meliputi edukasi, pendapatan, pekerjaan, dan ketersediaan fasilitas menyusui (Wilson et al., 2020).

3. Gangguan mental (kecemasan, depresi postpartum)

Masa puerperium dengan segala perubahan kondisi dan proses adaptasi yang terjadi pada masa tersebut dapat memicu gangguan mental pada ibu postpartum. Depresi, kecemasan, dan stres, merupakan gangguan psikologis sering terjadi selama masa puerperium. Periode pascapersalinan merupakan masa dengan peningkatan kerentanan terhadap munculnya atau kambuhnya gangguan psikologis akibat tantangan baru serta berbagai perubahan fisiologis dan psikososial. Sekitar 15% wanita mengalami gejala depresi pascapersalinan. Meskipun kecemasan kurang banyak diteliti, prevalensinya diperkirakan berkisar 11–17% pada masa pascapersalinan. Stres psikologis lebih sulit untuk diukur, dan hanya sedikit penelitian yang dilakukan untuk memperkirakan prevalensinya. Stres antenatal, kecemasan, dan depresi masing-masing telah diketahui berhubungan dengan hasil kehamilan yang buruk, seperti berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur, serta gangguan perkembangan saraf yang berdampak pada aspek emosional, perilaku, dan kognitif anak. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menangani gangguan ini demi kesehatan ibu dan anak (Obrochta et al., 2020).

Depresi pasca persalinan (PPD) merupakan salah satu komplikasi pasca persalinan yang umum terjadi dan dapat berdampak besar bagi kesehatan namun sering kali tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Gejala PPD mencakup perubahan suasana hati yang tidak stabil, kecemasan, mudah marah, merasa kewalahan,

serta kekhawatiran atau keasyikan berlebihan sering kali terkait dengan kesehatan bayi, pemberian makan, dan keselamatan saat mandi. Pikiran untuk bunuh diri cukup umum terjadi, dialami oleh sekitar 20% wanita dengan gejala PPD. Beberapa wanita dengan PPD juga memiliki pikiran untuk menyakiti anak mereka. Penting untuk membedakan antara pikiran berbahaya yang disertai niat dengan gejala obsesif, di mana wanita tersebut memiliki pikiran atau bayangan tentang menyakiti diri sendiri atau bayinya, namun merasa sangat terganggu oleh pikiran tersebut dan tidak memiliki niat untuk melakukannya. Patofisiologi depresi pascapersalinan bersifat kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Namun, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa faktor biologis, seperti hormon, genetika, dan fungsi sistem kekebalan tubuh, kemungkinan turut berperan dalam kondisi ini (Stewart & Vigod, 2019).

Managemen PPD yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Setelah PPD didiagnosis dan masalah medis maupun psikiatris yang menyertai ditangani, diperlukan strategi psikososial untuk membantu meningkatkan perawatan diri, memperkuat dukungan sosial baik secara praktis maupun emosional, serta mengurangi kejadian dan/atau dampak peristiwa hidup yang negatif atau menimbulkan stres bagi semua wanita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan aerobik dapat sedikit membantu mengurangi gejala PPD (Pritchett et al., 2017). Selain itu, intervensi yang berfokus pada perilaku tidur bayi, intervensi yang membantu meningkatkan durasi tidur ibu, juga dapat berkontribusi pada perbaikan suasana hati ibu. Saat mempertimbangkan intervensi tidur bayi, penting untuk menanyakan apakah ibu mampu tidur ketika bayi tidur, untuk membedakan antara insomnia dan kurang tidur yang wajar akibat merawat bayi. Bagi wanita dengan gejala PPD yang ringan, strategi psikososial seperti dukungan dari teman sebaya atau konseling nondirektif oleh tenaga profesional dapat menjadi pendekatan yang efektif (McCurdy et al., 2017).

E. Peran Keluarga dalam Perawatan Puerperium

Menjadi ibu adalah pengalaman yang berharga dan unik, namun masa pascapersalinan sering kali disertai dengan stres dan tekanan yang signifikan akibat perubahan yang terjadi secara cepat, baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi proses adaptasi pasca persalinan dibagi menjadi dua yaitu (Asadi et al., 2020):

1. Faktor personal

Faktor pribadi berperan penting dalam memengaruhi kemampuan individu beradaptasi terhadap perubahan pascapersalinan. Faktor-faktor tersebut meliputi

pengalaman sebelumnya, pola dan strategi dalam menghadapi masalah, karakteristik kepribadian, rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, serta tingkat kesadaran individu.

2. Faktor sosial

Faktor sosial merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan perannya dalam kontribusi proses adaptasi di masa puerperium. Faktor sosial disini meliputi keluarga dan kerabat, penyedia layanan kesehatan, konteks budaya, hukum dan peraturan.

a. Keluarga dan kerabat

keluarga dan kerabat berperan penting dalam memberikan dukungan kepada wanita pascapersalinan. Selama periode ini, anggota keluarga lainnya juga beradaptasi dengan situasi baru, termasuk perubahan pola perilaku, peran, dan cara berkomunikasi. Kepuasan dan interaksi dalam pernikahan, seperti pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan hubungan intim, juga dapat terpengaruh. interaksi keluarga, khususnya hubungan dengan pasangan, merupakan faktor risiko utama dalam terjadinya depresi pascapersalinan. Penelitian deskriptif lainnya mengungkapkan bahwa kesepian sering dialami dalam 2-8 minggu pertama setelah melahirkan. hubungan pernikahan yang buruk berkontribusi besar terhadap munculnya dan berlanjutnya depresi pascapersalinan. Selain itu, depresi pada ayah sebagai faktor yang dapat memperburuk ketidakmampuan beradaptasi selama periode pascapersalinan. Lebih lanjut, dukungan keluarga terbukti berperan positif dalam meningkatkan kesadaran diri pascapersalinan, menghadapi proses persalinan, dan membantu wanita kembali ke dunia kerja.

b. Pemberi layanan kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran krusial dalam mendukung penyesuaian diri ibu selama masa pascapersalinan. Mereka dapat membantu ibu dengan berbagai cara, seperti memberikan edukasi terkait perawatan diri dan bayi, membantu mengurangi stres, serta merespons pertanyaan dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki ibu.

c. Konteks budaya

Penyesuaian diri pascapersalinan membutuhkan beragam sumber daya, dan pemanfaatan sumber daya ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Dalam konteks ini, jika suami terlalu terikat pada peran gender tradisional dan enggan membantu ibu pascapersalinan, maka salah satu bentuk dukungan penting akan hilang. Penerimaan terhadap tuntutan berat dalam peran sebagai ibu turut berpengaruh pada proses penyesuaian tersebut. Wanita yang hidup di masyarakat yang sangat menghargai peran ibu dan menganggap memiliki

anak sebagai tujuan utama cenderung beradaptasi lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan di mana menjadi ibu bukanlah prioritas utama. Selain itu, beragam kepercayaan budaya terkait masa pascapersalinan berpotensi membahayakan kesehatan wanita dengan membatasi pendidikan yang tidak selaras dengan norma budaya setempat.

d. Hukum dan peraturan

Kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku dapat membantu ibu dalam menjalani masa nifas dan memenuhi kebutuhannya. Suatu contoh Dukungan dari laki-laki dapat diberikan jika mereka hadir secara fisik di rumah, sehingga "cuti ayah" sebaiknya menjadi bagian dari kebijakan nasional. Selain itu, keberadaan fasilitas yang dapat diandalkan, seperti pusat penitipan anak, dapat membantu perempuan yang merasa khawatir akan tanggung jawab sosial dan pekerjaan mereka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kehilangan pendapatan, peningkatan tanggung jawab, beragam tugas, dan minimnya dukungan sosial merupakan tantangan umum pada masa nifas. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang memadai bagi perempuan pascanifas dapat mengurangi kecemasan dan kesulitan yang mereka hadapi, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Ibu postpartum yang mendapatkan dukungan dari keluarga inti, keluarga besar, maupun pihak di luar keluarga cenderung lebih dapat menjalankan fungsinya lebih baik dibandingkan dengan ibu yang tidak menerima dukungan tersebut. Selain berperan dalam memberikan stabilitas selama masa transisi perempuan menjadi ibu, jaringan pendukung juga berfungsi sebagai fasilitator dalam berbagai aspek, seperti pemberian orientasi, dukungan emosional, bantuan dalam merawat bayi, menyusui, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memperkuat jaringan ini sangat penting untuk mendorong perilaku yang mendukung promosi dan pencegahan kesehatan, serta mengurangi risiko morbiditas dan kondisi yang memburuk. Kehadiran aktif figur ayah di luar peran sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga berhubungan dengan peningkatan fungsi perempuan. Peran ayah dalam mendukung ibu nifas mencakup pemberian perawatan bagi ibu dan bayinya, membantu pekerjaan rumah tangga, menyediakan transportasi, serta menemani ke tempat umum atau janji temu medis. Selain itu, pemahaman ayah mengenai pentingnya waktu dan dedikasi dalam proses menyusui turut berkontribusi pada keberlangsungan pemberian ASI eksklusif. Dukungan dari anggota keluarga lain, teman, atau tetangga berperan penting. Dukungan tersebut berkontribusi pada peningkatan mobilitas, perawatan diri, interaksi sosial, aktivitas sehari-hari (termasuk pekerjaan

rumah tangga dan pekerjaan formal), serta partisipasi, dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan dukungan. Dukungan terutama dari keluarga merupakan hal mendasar bagi stabilitas dan pemulihan fungsi selama masa nifas (Alves et al., 2022).

F. Simpulan

Peran keluarga berupa memberikan dukungan dan bantuan perawatan kepada ibu di masa puerperium sangat penting dan dapat memberikan dampak yang besar. Dukungan dari keluarga baik keluarga inti ataupun keluarga besar dapat membantu ibu menjalani proses adaptasi selama masa puerperium. Ibu postpartum mengalami perubahan baik anatomis, fisiologis dan juga psikososial yang dapat memicu gangguan atau risiko komplikasi yang beragam. Dukungan sosial, terutama dari keluarga inti, keluarga besar, dan lingkungan sekitar, terbukti berperan penting dalam membantu ibu menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Dukungan tersebut mencakup stabilitas emosional, bantuan dalam merawat bayi, hingga mendukung praktik menyusui. Kehadiran aktif figur ayah juga berkontribusi besar dalam membantu ibu melalui berbagai peran seperti memberikan perawatan, mendukung aktivitas rumah tangga, serta menemani ke janji medis. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) mengembangkan program yang dapat meningkatkan dukungan keluarga kepada ibu pada masa puerperium. 2) edukasi dan perawatan mandiri postpartum tidak hanya diajarkan kepada ibu postpartum tetapi juga kepada keluarga terutama pasangan.

G. Referensi

- Aisien, A. O. (2021). *The Puerperium BT - Contemporary Obstetrics and Gynecology for Developing Countries* (F. Okonofua, J. A. Balogun, K. Odunsi, & V. N. Chilaka (eds.); pp. 257–262). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75385-6_22
- Alves, A. B., Pereira, T. R. C., Aveiro, M. C., & Cockell, F. F. (2022). Functioning and support networks during postpartum. *Revista Brasileira de Saude Materno Infantil*, 22(3), 667–673. <https://doi.org/10.1590/1806-9304202200030013>
- Asadi, M., Noroozi, M., & Alavi, M. (2020). Factors Affecting Women's Adjustment to Postpartum Changes: A Narrative Review. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 25(6). https://journals.lww.com/jnmr/fulltext/2020/25060/factors_affecting_women_s_adjustment_to_postpartum.3.aspx
- Boushra, M., & Rahman, O. (2023). *Postpartum Infection*. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL). <http://europepmc.org/abstract/MED/32809639>

- Finlayson, K., Crossland, N., Bonet, M., & Downe, S. (2020). What matters to women in the postnatal period: A meta-synthesis of qualitative studies. *PLOS ONE*, 15(4), e0231415. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231415>
- Frilasari, H., Saudah, N., Prameswari, V. E., Azizah, Y. N., & Suhita, B. M. (2020). Nutritional Pattern And Healing Of Perineum Wound On Postpartum Period. *Journal Of Nursing Practice*, 3(2), 172–180. <https://doi.org/10.30994/jnp.v3i2.85>
- Govahi, M., Behmanesh, F., Gholinia, H., Omidvar, S., & Adib-Rad, H. (2024). Health-promoting lifestyle in mothers with vaginal childbirth and cesarean section in the postpartum period. *BMC Women's Health*, 24(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-02984-6>
- Jones, P. A. T., Ruchat, S.-M., Khan-Afridi, Z., Ali, M. U., Matenchuk, B. A., Leonard, S., Jantz, A. W. E., Vander Leek, K., Maier, L., Osachoff, L., Hayman, M. J., Forte, M., Sivak, A., & Davenport, M. H. (2025). Impact of postpartum physical activity on maternal sleep: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, bjsports-2024-108839. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2024-108839>
- Khademi, K., & Kaveh, M. H. (2024). Social support as a coping resource for psychosocial conditions in postpartum period: a systematic review and logic framework. *BMC Psychology*, 12(1), 301. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01814-6>
- Lambermon, F., Vandenbussche, F., Dedding, C., & van Duijnhoven, N. (2020). Maternal self-care in the early postpartum period: An integrative review. *Midwifery*, 90, 102799. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102799>
- Luo, Linfeng, Wan, Junhui, Chen, Xinping, Zhang, Huan, Zhang, Minjie, & Chen, Qi. (2021). Uterine necrosis, infection, and subinvolution: complications observed after combined application of modified B-Lynch suture and vascular ligation. *Journal of International Medical Research*, 49(5), 03000605211010730. <https://doi.org/10.1177/03000605211010730>
- Magdalena Agu Yosali, Elpinaria Girsang, Tisna Yant, & Siti Hanifatun Fajria. (2021). Factors that Influence Self-Efficacy in Maintaining Personal Hygiene of Postpartum Mothers. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(2), 2780–2785. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.14793>
- Marshall, N. E., Abrams, B., Barbour, L. A., Catalano, P., Christian, P., Friedman, J. E., Hay, W. W., Hernandez, T. L., Krebs, N. F., Oken, E., Purnell, J. Q., Roberts, J. M., Soltani, H., Wallace, J., & Thornburg, K. L. (2022). The importance of nutrition in pregnancy and lactation: lifelong consequences. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 226(5), 607–632. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.12.035>

- McCurdy, A. P., Boulé, N. G., Sivak, A., & Davenport, M. H. (2017). Effects of Exercise on Mild-to-Moderate Depressive Symptoms in the Postpartum Period: A Meta-analysis. *Obstetrics & Gynecology*, 129(6). https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/2017/06000/effects_of_exercise_on_mild_to_moderate_depressive.19.aspx
- McLintock, C. (2020). Prevention and treatment of postpartum hemorrhage: focus on hematological aspects of management. *Hematology*, 2020(1), 542–546. <https://doi.org/10.1182/hematology.2020000139>
- Obrochta, C. A., Chambers, C., & Bandoli, G. (2020). Psychological distress in pregnancy and postpartum. *Women and Birth*, 33(6), 583–591. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.01.009>
- Paladine, H. L., Blenning, C. E., & Strangas, Y. (2019). Postpartum Care: An Approach to the Fourth Trimester. *American Family Physician*, 100(8), 485–491.
- Perichart-Perera, O. (2025). Nutrition for Optimal Lactation. *Annals of Nutrition & Metabolism*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1159/000541757>
- Petersohn, I., Hellinga, A. H., van Lee, L., Keukens, N., Bont, L., Hettinga, K. A., Feskens, E. J. M., & Brouwer-Brolsma, E. M. (2023). Maternal diet and human milk composition: an updated systematic review. *Frontiers in Nutrition*, 10(January), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1320560>
- Pritchett, R. V., Daley, A. J., & Jolly, K. (2017). Does aerobic exercise reduce postpartum depressive symptoms?: A systematic review and meta-analysis. *British Journal of General Practice*, 67(663), e684–e691. <https://doi.org/10.3399/bjgp17X692525>
- Putu, A. P., Rejeki, D. S. S., & Pramutama, S. (2024). Faktor- Faktor Risiko Kematian Ibu Di Beberapa Negara Berkembang "Literature Review." *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 10(3), 472–482. <https://doi.org/10.22487/htj.v10i3.1356>
- Qi, W., Liu, Y., Lv, H., Ge, J., Meng, Y., Zhao, N., Zhao, F., Guo, Q., & Hu, J. (2022). Effects of family relationship and social support on the mental health of Chinese postpartum women. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04392-w>
- Ritonga, C. M. T., Sofinia, H., Viky, M., & Rokibullah. (2022). The Physiological Changes In The Postpartum Period After Childbirth. *Asian Journal of Social and Humanities*, 01(03), 105–118. <https://ajosh.org/>
- Sampieri, C. L., & Montero, H. (2019). Breastfeeding in the time of Zika: a systematic literature review. *PeerJ*, 7, e6452. <https://doi.org/10.7717/peerj.6452>
- Schobinger, E., Vanetti, M., Ramelet, A.-S., & Horsch, A. (2022). Social support needs of first-time parents in the early-postpartum period: A qualitative study. *Frontiers in Psychiatry*, 13.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.1043990>

- Schrey-Petersen, S., Tauscher, A., Dathan-Stumpf, A., & Stepan, H. (2021). Diseases in the puerperium. *Deutsches Arzteblatt International*, 118(25), 436–446. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0168>
- Sendas, M. V., & Freitas, M. J. (2024). "The needs of women in the postpartum period: A scoping review." *Midwifery*, 136, 104098. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.104098>
- Stewart, D. E., & Vigod, S. N. (2019). Postpartum depression: Pathophysiology, treatment, and emerging therapeutics. *Annual Review of Medicine*, 70, 183–196. <https://doi.org/10.1146/annurev-med-041217-011106>
- Stuebe, A., Borders, A. E., & Bingham, D. (2016). Optimizing Postpartum Care. *Obstetrics and Gynecology*, 127(6), 1192–1193. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001481>
- Vesco, K. K., Dietz, P. M., Rizzo, J., Stevens, V. J., Perrin, N. A., Bachman, D. J., Callaghan, W. M., Bruce, F. C., & Hornbrook, M. C. (2009). Excessive Gestational Weight Gain and Postpartum Weight Retention Among Obese Women. *Obstetrics & Gynecology*, 114(5). https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/2009/11000/excessive_gestational_weight_gain_and_postpartum.17.aspx
- Wilson, Emily, Woodd, Susannah L, & Benova, Lenka. (2020). Incidence of and Risk Factors for Lactational Mastitis: A Systematic Review. *Journal of Human Lactation*, 36(4), 673–686. <https://doi.org/10.1177/0890334420907898>
- Wolpern, A. E., Bardsley, T. R., Brusseau, T. A., Byun, W., Egger, M. J., Nygaard, I. E., Wu, J., & Shaw, J. M. (2021). Physical activity in the early postpartum period in primiparous women. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 24(11), 1149–1154. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsams.2021.06.009>

H. Glosarium

PPH = *Postpartum Hemorrhaghe*

ASI = Air Susu Ibu

PPD = *Post Partum Depression*

CHAPTER 4

DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP REMAJA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN FISIK

Ns. Siti Munawaroh, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Pertumbuhan manusia melibatkan beberapa tahap penting dalam kehidupannya, salah satunya adalah masa remaja. Pada tahap ini, seseorang belum sepenuhnya dianggap dewasa, namun juga tidak lagi disebut anak-anak. Masa remaja adalah periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang berlangsung antara usia 11 – 21 tahun (Irianto, K, 2015). Namun, dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, yang disebut remaja adalah penduduk yang berusia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2007), yang termasuk remaja adalah seseorang yang berusia 10 sampai 24 tahun serta belum menikah.

Remaja memegang peran yang sangat vital bagi masa depan sebuah negara. Mereka adalah individu-individu yang kelak akan memasuki usia produktif dan menjadi agen pembangunan, sehingga perlu dipersiapkan untuk menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pada periode ini, banyak perubahan kompleks yang terjadi, sehingga pemahaman yang mendalam, sangat dibutuhkan, terutama dari diri remaja itu sendiri. Proses perkembangan remaja rentan terhadap berbagai risiko, sehingga memerlukan kondisi kesehatan yang baik (Wirenviona, et al., 2020).

Remaja akan mengalami perkembangan biologis, yaitu suatu fase di mana mereka mencapai kematangan organ seksual yang memungkinkan mereka untuk berkembang biak, yang dikenal sebagai pubertas. Masa ini ditandai dengan perubahan hormonal yang menyebabkan terjadinya menstruasi pertama pada remaja perempuan, yang disebut *menarche*, sedangkan pada remaja laki-laki, pubertas ditandai dengan ejakulasi pertama yang sering terjadi saat tidur, yang dikenal sebagai mimpi basah (Agustinus, dkk, 2018).

Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru, termasuk berhubungan seksual di luar pernikahan. Seks pranikah pada remaja merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan sebelum mereka menikah (BKKBN, 2007). Ketika remaja memasuki masa

peralihan tanpa pengetahuan yang cukup mengenai seks pranikah, hal ini bisa disebabkan oleh kecanggungan orang tua dalam membicarakan masalah seksual dengan anak-anak mereka, serta hubungan orang tua dan anak yang semakin jauh, sehingga anak lebih cenderung mencari informasi dari sumber lain, terutama teman-temannya (Sarwono, 2013).

Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sehat secara fisik, psikologis, dan sosial yang berkaitan dengan fungsi dan proses sistem reproduksi pada remaja (WHO, 2018). Kondisi sehat ini mencakup sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengetahuan mengenai kesehatan di sini tidak hanya berarti bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental, sosial, dan kultural yang terkait dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan sekadar kondisi yang bebas dari penyakit atau cacat (Irianto, K, 2015).

B. Tahap Tumbuh Kembang Remaja

Tahapan tumbuh kembang remaja terdiri dari beberapa tahap dengan karakteristik yang khas di masing-masing tahapannya. Smetana (2011) membagi tumbuh kembang remaja menjadi tiga tahapan berikut (Wirenviona, *et al.* 2020).

1. Remaja Awal (11-13 tahun/*early adolescence*)

Remaja cenderung merasa lebih dekat dengan teman sebaya dan memiliki sifat egosentris, serta keinginan untuk meraih kebebasan. Remaja yang egosentris sering kali kesulitan melihat sesuatu dari perspektif orang lain, sehingga mereka cenderung tidak menyadari apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dilihat oleh orang lain. Mereka lebih sulit untuk menyesuaikan diri atau mengoreksi pandangannya jika dirasa pandangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi atau lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, remaja sering mencari teman sebaya yang memiliki kesamaan untuk membantu mengatasi ketidakstabilan yang dirasakannya.

Kematangan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan terjadi pada usia yang berbeda. Remaja laki-laki umumnya mengalaminya antara usia 10-13,5 tahun, sementara remaja perempuan pada usia 9-15 tahun. Pada tahap awal ini, remaja cenderung lebih memperhatikan kondisi tubuhnya dari aspek seksual, yang ditandai dengan meningkatnya ketertarikan terhadap anatomi seksual. Selain itu, mereka sering merasa cemas dan memiliki banyak pertanyaan mengenai perubahan pada alat kelamin dan ukurannya (Agustinus, dkk., 2018).

Pada usia ini, anak menunjukkan minat terhadap kehidupan sehari-hari dan rasa ingin tahu yang tinggi, yang ditandai dengan keinginan untuk belajar, meskipun mereka masih menunjukkan sikap yang cenderung kanak-kanak. Secara kognitif, karakteristik mereka mencakup cara berpikir yang masih konkret,

kesulitan dalam melihat dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil saat ini, serta memiliki moralitas yang bersifat konvensional.

2. Remaja Pertengahan (14-17 tahun/*middle adolescence*)

Pada masa remaja pertengahan, perkembangan fisik semakin sempurna. Beberapa hal yang terjadi antara lain pencarian identitas diri, munculnya keinginan untuk berkencan dengan lawan jenis, serta berkhayal mengenai aktivitas seksual. Perkembangan intelektual juga semakin baik, seiring dengan pemahaman mengenai fungsi seksual, yang ditandai dengan menstruasi pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki. Remaja mengalami perubahan fisik yang mencolok, dengan munculnya ciri-ciri seks sekunder pada baik perempuan maupun laki-laki. Pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja dapat optimal jika didukung oleh pemenuhan gizi yang cukup. Oleh karena itu, perhatian yang memadai dari orang tua sangat penting agar remaja dapat beradaptasi dengan baik dalam penerimaan sosial.

Ciri-ciri seks sekunder pada remaja perempuan antara lain pembesaran pinggul dan pantat, kulit yang lebih halus, serta peningkatan tinggi dan berat badan. Perkembangan payudara biasanya dimulai antara usia 8-10 tahun. Kelenjar keringat juga mulai aktif, yang ditandai dengan peningkatan produksi keringat. Rambut pada ketiak dan alat kelamin mulai tumbuh. Sedangkan pada remaja laki-laki, perubahan yang terlihat antara lain suara yang menjadi lebih berat, tumbuhnya jakun, serta peningkatan tinggi dan berat badan. Rambut pada ketiak, alat kelamin, dada, dan wajah mulai tumbuh. Pundak dan dada menjadi lebih besar dan bidang. Kelenjar keringat juga aktif, sehingga produksi keringat meningkat. Pada alat reproduksi, penis dan buah zakar juga membesar.

3. Remaja Akhir (18-21 tahun/*late adolescence*)

Remaja akhir, yang juga dikenal sebagai dewasa muda, mulai meninggalkan dunia kanak-kanak. Proses transisi dalam nilai-nilai moral dimulai dengan peralihan dari nilai-nilai yang telah dianut selama ini ke nilai-nilai yang dipegang oleh orang dewasa. Pada tahap ini, remaja menjadi lebih selektif dalam memilih teman sebaya, mengembangkan citra tubuh (*body image*), serta belajar untuk mengekspresikan rasa cinta dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada. Mereka juga mulai merasakan tanggung jawab untuk memperoleh pendidikan yang baik atau mencari pekerjaan yang stabil.

Remaja pada tahap ini memiliki sifat yang khas, yaitu kemandirian dan belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Mereka cenderung menyukai petualangan dan tantangan serta berani mengambil risiko, meskipun kadang-kadang tanpa pertimbangan yang matang. Remaja dalam tahap ini masih berlatih dalam pengambilan keputusan, dan jika keputusan yang

diambil ternyata salah, mereka bisa terjerumus dalam perilaku berisiko dan harus menghadapi konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang, baik dalam hal kesehatan fisik maupun masalah psikososial.

C. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja

Jurnal Ikalor (2013) dalam (Punkasaningtyas, 2017) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja antara lain :

1. Faktor Hereditas

Warisan atau bawaan sejak lahir atau keturunan dari orangtua dapat mempengaruhi perkembangan remaja. Fakta dilapangan membuktikan beberapa remaja yang berkembang tidak jauh berbeda dengan orangtuanya

2. Faktor Lingkungan

Individu hidup di sebuah lingkungan, sehingga individu tidak bisa lepas dari lingkungan tersebut. Segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan dimana remaja berada, pasti akan memberi pengaruh pada perkembangannya. Beberapa yang termasuk faktor lingkungan yaitu teman sebaya, media massa (media sosial) dan keluarga

3. Kematangan Fungsi-Fungsi Organ dan Psikis

Sejalan dengan bertambahnya waktu, remaja semakin matang fungsi organ dan psikisnya, semakin berkembang juga perkembangan remaja ke yang lebih luas

4. Aktivitas individu sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan seleksi, dapat menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha membangun diri sendiri

D. Bentuk dan Fungsi Dukungan keluarga

Dukungan keluarga merupakan dukungan yang dapat diberikan kepada anggota keluarga lainnya dalam bentuk barang, jasa, informasi dan nasehat yang dapat membuat penerima dukungan merasa dicintai, dihargai dan damai. Dukungan tersebut merupakan sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap pasien. Anggota keluarga menyadari bahwa orang yang mendukung akan selalu tersedia untuk memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Dukungan diterima oleh salah satu anggota lainnya untuk menjalankan fungsi keluarga.

Dukungan keluarga sangat diperlukan remaja dalam masa pertumbuhannya, dukungan keluarga yang kurang dapat menimbulkan stres psikologis pada remaja (Yusuf, 2015). Dukungan orang tua membantu remaja dengan citra diri yang baik mengembangkan kematangan emosi (Putri et al., 2021). Remaja dengan dukungan keluarga yang kuat memiliki konsep diri yang lebih baik (Pendit et al., 2019)

Hasil penelitian Lailah, Soimah, dkk. (2024), menunjukkan bahwa terdapat

hubungan positif yang signifikan namun lemah antara dukungan keluarga dengan kecerdasan emosional remaja Madrasah Aliyah, hal ini menunjukkan semakin meningkat dukungan keluarga maka semakin besar pula kecerdasan emosional siswa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari, Puspa, dkk. (2025), ditemukan hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan sikap remaja terhadap menarche. Hasil serupa juga ditemukan oleh Dyah (2010), yang memperoleh nilai korelasi sebesar 0,416 antara persepsi komunikasi orang tua dan remaja dengan konsep diri, dengan p value 0,000. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara persepsi komunikasi orang tua dan remaja dengan konsep diri pada remaja.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa remaja yang menerima dukungan keluarga yang tinggi cenderung memiliki gambaran diri yang positif. Sebaliknya, remaja yang memiliki dukungan keluarga yang rendah lebih mungkin memiliki gambaran diri yang negatif. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Thompson dalam Henggaryadi dan Fakhurrozi (2008), yang menyatakan bahwa keluarga (terutama orang tua) merupakan faktor penting dalam mempengaruhi gambaran diri remaja, karena orang tua berperan sebagai model dalam proses sosialisasi, yang pada gilirannya mempengaruhi body image anak.

Berbeda dengan penelitian Chasanah, Uswatun S. & Sekarwati, Novita (2023), yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dengan kecemasan remaja putri dalam menghadapi perubahan fisik pada masa pubertas. Dukungan orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan yang diberikan oleh orangtua kepada anak yang membuat anak merasa disayangi dan dicintai, meliputi dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan penghargaan.

Bentuk dukungan keluarga terhadap anggota keluarga ada yang bersifat rohani maupun materiil. Bentuk dan fungsi dukungan keluarga menurut Friedman (2010) dibagi menjadi 4 aspek, yaitu:

1. Dukungan emosional

Dukungan emosional adalah keluarga merupakan tempat yang aman, tenteram, tenang untuk beristirahat, memulihkan diri dan membantu mengendalikan emosi. Aspek dukungan emosional meliputi dukungan yang diungkapkan dalam bentuk kasih sayang, kepercayaan, perhatian, mendengarkan, dan didengarkan. Dukungan emosional termasuk menunjukkan empati dan perhatian. Memberikan dorongan, kehangatan pribadi, cinta atau dukungan emosional.

2. Dukungan materi

Dukungan materi artinya keluarga adalah sumber bantuan Dukungan praktis dan spesifik, terutama mengenai kebutuhan finansial, makanan, minuman, dan istirahat.

3. Dukungan informasi

Dukungan informasi dimana keluarga berperan sebagai pemberi informasi, dimana keluarga menjelaskan dengan memberikan nasehat, saran, informasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu permasalahan. Aspek dukungan tersebut berupa nasehat, saran, rekomendasi, bimbingan dan pemberian informasi.

4. Dukungan Evaluasi atau Apresiasi

Dukungan Evaluasi atau Apresiasi adalah dimana keluarga berperan membimbing dan mengapresiasi pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga, termasuk dukungan, penghargaan dan perhatian.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga menurut Rustiana (2011) yaitu:

1. Faktor Internal

a. Tahap Perkembangan

Tahap perkembangan ini berkaitan dengan usia. Dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga dapat bervariasi berdasarkan usia (dari bayi hingga lanjut usia). Karena mendampingi anak kecil dan orang tua sangatlah berbeda. Hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien karena pemberian dukungan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Sebab, jika anggota keluarga tidak mendapat dukungan yang memadai, maka motivasi pasien untuk cepat sembuh akan berkurang.

b. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan tercermin dari kapasitas pikiran, dan orang yang memiliki pendidikan, pengetahuan, pelatihan dan pengalaman yang baik akan dengan mudah menciptakan cara berpikir. Keterampilan kognitif ini memungkinkan pasien untuk dengan mudah memahami apa yang terjadi pada mereka dan menggunakan pengetahuan mereka untuk menjaga kesehatan mereka.

c. Faktor Emosi

Kondisi emosional dapat mempengaruhi kepercayaan diri pasien terhadap pengobatan. Pasien yang mengalami stres saat menerima pengobatan menjadi kurang reaktif dan lebih cemas. Berbeda dengan pasien

yang tampak tenang, mereka kurang memiliki intensitas emosi dan motivasi positif dari diri sendiri dan keluarganya.

d. Spiritual

Aspek spiritual dapat dilihat pada kehidupan pasien dan keyakinannya, aspek spiritual juga dapat dilihat pada hubungan pasien dengan keluarga, teman, pasangan dan pencarian harapan dalam hidup yaitu dalam hidupnya. gairah untuk penyembuhan. Karena penyakit yang dideritanya.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan risiko penyakit dan memengaruhi cara seseorang mengidentifikasi dan merespons penyakitnya. Variabel psikososial meliputi stabilitas perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan kerja. Seseorang sering kali mencari dukungan dan persetujuan dari kelompok sosialnya, yang akan memengaruhi keyakinannya terhadap kesehatan dan cara penerapannya. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, maka umumnya akan semakin cepat pula respon terhadap gejala penyakit. Oleh karena itu, ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada masalah pada kesehatannya.

b. Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya memengaruhi keyakinan, nilai, dan praktik individu dalam pemberian dukungan, termasuk bagaimana kesehatan pribadi diwujudkan.

F. Simpulan

Remaja akan mengalami perubahan fisik dalam masa pertumbuhannya, hal ini dapat menimbulkan permasalahan kesehatan dan dampak psikologis pada remaja jika tidak dipersiapkan dengan baik. Dukungan keluarga merupakan salah satu upaya dalam mencegah permasalahan kesehatan yang bisa dialami oleh remaja, dengan dukungan keluarga yang baik diharapkan remaja menjadi lebih siap dalam menghadapi perubahan fisik yang dialaminya. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Mengembangkan dan menyediakan pelayanan kesehatan remaja (jika belum ada), meningkatkan kegiatan posyandu remaja; 2) Melibatkan dan meningkatkan peran keluarga dalam menyelesaikan setiap masalah kesehatan remaja.

G. Referensi

- Agustinus, dkk. (2018). *Biologi Reproduksi Pria*. Surabaya : Airlangga University Press.
- BKKBN. (2007). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Cetakan ke-5. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Chasanah, Uswatun S. & Sekarwati, Novita. (2023). Hubungan Dukungan Orang Tua Dengan Kecemasan Remaja Putri Dalam Menghadapi Perubahan Fisik Pada Masa Pubertas Siswi Smp Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Volume 16, Nomor 2
- Dyah, (2010). Hubungan Antara Persepsi Komunikasi Orang Tua -Remaja Dengan Konsep Diri Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia*.
- Friedman. (2010). *Buku ajar keperawatan keluarga: Riset, Teori dan Praktek*. Jakarta : EGC
- Hapsari, Puspa, dkk. (2025). Dukungan Keluarga Meningkatkan Sikap Remaja dalam Menghadapi Menarche. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*. Vol. 17 No. 1
- Henggaryadi, G., dan Fakhurrozi, M. (2008). Relationship Between Body Image and Self-Esteem in Adolescent Men Taking Exercise. *Journal of Faculty of Psychology Gunadarma University*
- Irianto, K. (2015). *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Human Reproductive .Biology Untuk Paramedis dan Nonparamedis*. Bandung : Alfabeta
- Lailah, Soimah, dkk. (2024). Kajian Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kecerdasan Emosional di Kalangan Pelajar Madrasah Aliyah. *Jurnal Psikologi Malahayati*. Vol. 6, No. 2
- Pendit, S. A., Astika, T., & Supriyatna, N. (2019). Analisis Pengaruh Dukungan Keluarga, Dan Faktor Lainnya Terhadap Pemberian Imunisasi Mr Pada Balita. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(1), 322–331. <https://doi.org/10.31539/Jks.V3i1.848>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/117562/permenkes-no-25-tahun-2014>
- Punkasaningtyas, R. (2017). *Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Kualitas Tidur, Kestabilan Emosi dan Kecemasan Sosial pada Remaja Di SMAN 20 Surabaya*. Skripsi 2(1):2–6. <https://repository.unair.ac.id/76642/>.
- Putri, R. N., Hidayah, N., & Mujidin. (2021). Penyesuaian Diri, Dukungan Sosial, Dan Gaya Belajar Visual: Kontribusi Terhadap Stres Akademik Siswa Di Masa Pandemi. *Psyche 165 Journal*, 339–345.
- Rustiana. (2011). *Faktor-faktor Dukungan Keluarga dengan Pengetahuan Keluarga pada Lanjut Usia Penderita Hipertensi Kabupaten Boyolali*. Boyolali: Mulia Press

- Sarwono, Bahri. (2013). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- WHO. (2018). *WHO Recommendations on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275374/9789241514606-eng.pdf?ua=1>
- Wirenviona, et al. (2020). *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Yusuf, L. (2015). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

H. Glosarium

SDM = Sumber Daya Manusia

CHAPTER 5

PERAN KELUARGA DALAM PEMULIHAN PASCA KEGUGURAN

Ns. Eny Dewi Pamungkas, M.Kep, Sp.Kep. M.

A. Memahami Keguguran

Kementerian Kesehatan RI (2020) menyatakan bahwa keguguran adalah kondisi berhentinya kehamilan sebelum mencapai 20 minggu atau berat janin <500 gram, baik secara spontan maupun induksi. Sampai saat ini masih banyak yang menganggap bahwa faktor penyebab keguguran adalah bekerja, olahraga, mual muntah, dan berhubungan seks. Sebagian wanita juga percaya bahwa keguguran disebabkan oleh jatuh, pukulan, ketakutan, atau stres. Dalam kebanyakan kasus, hal ini tidak benar. Mungkin saja hal ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan kondisi keguguran terjadi. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (2024) menyebutkan bahwa setengah dari peristiwa keguguran terjadi karena embrio tidak berkembang dengan baik. Hal ini sering kali disebabkan oleh jumlah kromosom yang tidak normal. Selama pembuahan, ketika sel telur dan sperma bergabung, dua set kromosom bersatu. Jika sel telur atau sperma memiliki lebih banyak atau lebih sedikit kromosom dari biasanya, embrio juga akan memiliki jumlah yang tidak normal. Hal ini dapat menyebabkan keguguran. National Health Service (NHS), (2022) dan Kementerian Kesehatan RI (2020) juga mengatakan bahwa penyebab terjadinya keguguran yaitu kelainan kromosom, masalah plasenta, merokok, konsumsi alkohol dan obat-obatan, kondisi kesehatan ibu seperti autoimun, diabetes gestasional, hipertensi, serta infeksi.

Keguguran diklasifikasikan menjadi keguguran spontan yaitu keguguran yang terjadi tanpa sengaja dan keguguran induksi yaitu keguguran yang terjadi secara sengaja dengan obat-obatan atau alat. Menurut jenisnya, keguguran dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Keguguran iminens (*threatened miscarriage*)

Ancaman keguguran yang terjadi sebelum usia 20 minggu dengan adanya sedikit perdarahan dari vagina dan kram rahim. Pada keguguran iminens jaringan kehamilan masih tetap bisa bertahan hidup karena tidak disertai dengan dilatasi serviks (Johns Hopkins Medicine, 2024; Kementerian Kesehatan RI, 2020).



Keguguran Iminens

2. Keguguran insipiens (*inevitable miscarriage*)

Keguguran yang tak terelakan yang terjadi sebelum usia 20 minggu dengan adanya perdarahan dari vagina, nyeri dan kram pada bagian bawah perut disertai dengan dilatasi serviks. Pada kondisi ini jaringan kehamilan masih ada di dalam uterus. (American Pregnancy Association, 2010; Kementerian Kesehatan RI, 2020; Miscarriage Australia, 2024)



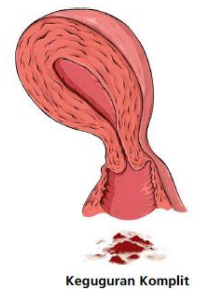
3. Keguguran inkomplit (*incomplete miscarriage*)

Keguguran inkomplit terjadi ketika sebagian jaringan kehamilan telah keluar disertai dengan perdarahan dari vagina, nyeri panggul, dan perut bagian bawah. Kondisi ini dapat mungkin memerlukan penanganan pembedahan untuk mengangkat jaringan yang tersisa. (American Pregnancy Association, 2010; Johns Hopkins Medicine, 2024; Kementerian Kesehatan RI, 2020; Miscarriage Australia, 2024)



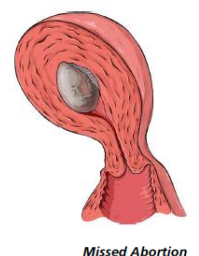
4. Keguguran komplit (*complete miscarriage*)

Keguguran komplit yang terjadi ketika semua jaringan kehamilan telah keluar dari rahim. Hal ini disertai dengan adanya perdarahan vagina dan nyeri perut. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) diperlukan untuk memastikan tidak ada jaringan janin yang tersisa di rahim. (American Pregnancy Association, 2010; Johns Hopkins Medicine, 2024; Kementerian Kesehatan RI, 2020; Miscarriage Australia, 2024)



5. Keguguran tanpa disadari (*missed miscarriage*)

Keguguran tanpa sadari terjadi ketika embrio atau janin telah mati tetapi tetap berada di dalam uterus. Kondisi ini juga dikatakan sebagai kehamilan yang berhenti berkembang. Seringkali tidak ada gejala yang dirasakan, sehingga pemeriksaan USG perlu dilakukan untuk memastikannya. (Johns Hopkins Medicine, 2024; Miscarriage Australia, 2024)



B. Tahapan Berduka Terhadap Peristiwa Keguguran

Menghadapi keguguran adalah perjalanan emosional yang mendalam, terutama jika keguguran mengakibatkan wanita kehilangan janinnya. Hal ini melibatkan berbagai tahapan berduka. Setiap tahapan membantu seseorang memproses rasa kehilangan dan perlahan menemukan kedamaian untuk melangkah ke depan dengan harapan baru. American Pregnancy Association (2024a) menjelaskan proses tahapan berduka terhadap peristiwa keguguran yaitu:

Tahap 1: Syok/Penyangkalan

*"Ini tidak benar-benar terjadi; saya sudah menjaga diri saya dengan baik."
"Mungkin dokter salah... mungkin saya masih hamil."*

Pada tahap awal ini, seseorang mungkin sulit mempercayai apa yang telah terjadi. Syok dan penyangkalan muncul sebagai cara untuk melindungi diri dari rasa sakit emosional yang terlalu berat. Pikiran berusaha mencari alasan untuk menyangkal kenyataan, seperti mempertanyakan diagnosa dokter atau mencari kemungkinan lain yang memberikan harapan palsu. Penyangkalan ini sering ditandai dengan keyakinan bahwa semua yang telah terjadi hanya kesalahpahaman. Namun, tahapan ini adalah mekanisme alami yang memungkinkan seseorang perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan realitas yang menyakitkan.

Tahap 2: Kemarahan/Rasa Bersalah/Depresi

"Mengapa saya? Jika saja saya bisa lebih berhati-hati..." "Saya sangat menginginkan bayi, ini tidak adil!"

Setelah kenyataan mulai disadari, emosi intens seperti kemarahan dan rasa bersalah sering mendominasi. Wanita mungkin menyalahkan diri sendiri atas keguguran, berpikir bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah atau gagal menjaga kehamilan. Kemarahan juga bisa diarahkan kepada orang lain, situasi, atau bahkan kepada Tuhan. Perasaan ini dapat diikuti oleh depresi mendalam, dengan gejala seperti kehilangan minat, menangis tanpa sebab yang jelas, dan merasa sangat kehilangan. Tahap ini sangat berat, tetapi penting untuk memahami bahwa perasaan ini adalah bagian dari proses berduka. Dukungan dari orang terdekat dan profesional kesehatan mental sangat membantu di tahap ini.

Tahap 3: Penerimaan

"Saya harus menghadapinya, saya bukan satu-satunya yang mengalami ini. Wanita lain telah berhasil melewati ini, mungkin saya harus mencari bantuan."

Penerimaan tidak berarti melupakan rasa kehilangan, tetapi menerima kenyataan yang ada dan mulai melangkah maju. Pada tahap ini, seseorang mulai menemukan cara untuk mengatasi rasa kehilangan, seperti mencari dukungan dari kelompok sebaya atau berbicara dengan konselor. Mereka mungkin juga menemukan kekuatan dalam cerita wanita lain yang telah melalui pengalaman serupa. Dengan berjalannya waktu, penerimaan memungkinkan individu untuk memandang masa depan dengan harapan baru, meskipun pengalaman keguguran tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka.

Keguguran merupakan peristiwa traumatis bagi seorang wanita yang berdampak terhadap kondisi fisik seperti perdarahan, nyeri, kelelahan, serta dalam beberapa kasus terjadinya komplikasi medis seperti infeksi atau kerusakan rahim. Selain itu, dampak emosional dari keguguran sering kali lebih kompleks. Wanita dapat merasakan berbagai emosi, seperti kesedihan, rasa bersalah, kemarahan, atau

kebingungan. Banyak yang merasa kehilangan besar atas bayi yang telah dinantikan, meskipun kehamilan baru berlangsung beberapa minggu. Perasaan ini diperburuk jika wanita menghadapi tekanan sosial atau stigma, seperti disalahkan atau dianggap lemah. Dampak psikologis pasca keguguran juga dapat memicu kondisi serius seperti kecemasan, depresi, hingga gejala *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Gejala yang muncul bisa meliputi kesulitan tidur, hilangnya minat pada aktivitas sehari-hari, atau bahkan mimpi buruk tentang pengalaman tersebut. Beban ini dapat memengaruhi hubungan dengan pasangan, keluarga, atau teman (National Health Service, 2022a; Quenby et al., 2021). Oleh karena itu, dukungan emosional dari orang-orang terdekat serta bantuan profesional sangat penting dalam proses pemulihan, membantu wanita bangkit dan menghadapi dampak keguguran dengan lebih kuat.

C. Keluarga dan Dukungan Pemulihan Pasca Keguguran

Begitu besar dampak keguguran bagi seorang wanita yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, psikologi, dan emosionalnya. Menurut penelitian Gold., Sen., & Hayward (2010) wanita yang mengalami keguguran memiliki risiko lebih besar untuk menghadapi perpisahan dalam hubungan dengan pasangannya, terutama jika tidak ada dukungan emosional yang memadai atau komunikasi yang efektif antara keduanya. Kehilangan janin dapat menjadi sumber stres tambahan yang signifikan dalam suatu hubungan. Perasaan kehilangan yang mendalam, rasa bersalah, atau stres yang dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak dapat menjadi pemicu ketegangan dalam hubungan. Bellhouse, Temple-Smith, & Bilardi (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sebagian besar wanita melaporkan kurangnya dukungan keluarga dan sosial setelah keguguran. Hal tersebut terjadi karena teman dan keluarganya tidak tahu bagaimana cara mendukung, atau karena mereka merasa orang lain tidak memahami kesedihan mereka dan mengabaikan permintaan bantuan mereka.

Dukungan dan peran keluarga sangat penting untuk proses pemulihan pasca keguguran (Alqassim, Kresnye, Siek, Lee, & Wolters, 2022; Yoon et al., 2023). Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung wanita yang mengalami keguguran, karena mereka adalah lingkaran terdekat yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman pada masa-masa sulit. Keguguran bukan hanya peristiwa medis, tetapi juga pengalaman yang dapat meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Dalam situasi seperti ini, wanita sering kali merasa kehilangan, kesedihan yang mendalam, bahkan perasaan bersalah. Kehadiran keluarga sebagai pendengar yang penuh empati dan tanpa menghakimi bisa menjadi langkah awal yang sangat berarti untuk proses pemulihan. Dukungan keluarga juga berfungsi

untuk mencegah wanita yang mengalami keguguran dari perasaan terisolasi. Banyak wanita merasa sendirian atau tidak dimengerti setelah mengalami keguguran, terutama di lingkungan yang kurang terbuka membicarakan hal-hal semacam itu. Dengan memberikan ruang untuk berbicara, mengungkapkan perasaan, atau bahkan menangis, keluarga membantu mengurangi tekanan emosional yang dialami.

1. Bagaimana Memberikan Dukungan Melalui Perhatian

Dukungan dan perhatian merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan wanita untuk meningkatkan kesejahteraan pada masa awal keguguran (Lee, Ma, Davies, & Kammers, 2023; Swanson, 1999). Kehilangan janin sering kali meninggalkan luka emosional yang dalam, seperti kesedihan, rasa bersalah, dan bahkan perasaan gagal. Dalam situasi seperti ini, keluarga dapat memberikan dukungan dengan cara-cara berikut (Miscarriage Association, 2024).

- a. Menunjukkan empati: Memahami perasaan wanita yang sedang berduka adalah langkah awal yang penting. Keluarga dapat menunjukkan empati dengan mengakui rasa kehilangan yang dirasakan tanpa meremehkan atau mengabaikannya. Sebagai contoh, seorang suami dapat berkata, *"Aku tahu ini sangat berat untukmu, tapi aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu."*
- b. Memberikan perhatian yang tulus: Kehadiran fisik maupun emosional dari anggota keluarga, seperti menemani, memeluk, atau sekadar berbicara, dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi rasa kesepian. Misalnya, seorang ibu dapat menawarkan diri untuk menghabiskan waktu bersama anaknya dengan mengatakan, *"Jika kamu butuh seseorang untuk bicara atau hanya ingin ditemani, Ibu selalu siap."*
- c. Memastikan dukungan berkelanjutan: Dukungan tidak hanya diberikan pada awal peristiwa, tetapi juga dalam jangka waktu panjang. Proses pemulihan emosional membutuhkan waktu, dan keluarga perlu hadir secara konsisten. Sebagai contoh, keluarga dapat mengingatkan wanita tersebut bahwa dia tidak sendiri dengan mengatakan, *"Kapan pun kamu butuh kami, jangan ragu untuk bilang. Kami akan selalu ada."*

Hal-hal yang harus dihindari

- a. Mengucapkan kalimat yang menyakitkan: Kalimat seperti *"Kamu harus segera melupakan ini"* atau *"Kamu bisa mencoba lagi nanti"* dapat memperburuk kondisi emosional. Sebaliknya, ucapkan kata-kata yang mendukung seperti *"Kami di sini untukmu"* atau *"Tidak apa-apa jika kamu merasa sedih."* Contohnya, seorang saudara dapat berkata, *"Tidak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk melewati ini. Aku akan selalu mendukungmu."*

- b. Menuntut wanita untuk cepat pulih: Setiap orang memiliki waktu pemulihan yang berbeda setelah keguguran. Hindari mendesak wanita untuk segera melupakan kejadian ini atau kembali ke rutinitasnya. Pernyataan seperti *"Kamu harus kuat demi kita"* atau *"Saatnya melanjutkan hidup"* bisa terasa memaksa dan mengurangi ruang bagi wanita untuk memproses kesedihannya. Sebaliknya, beri waktu dan ruang bagi wanita untuk menyembuhkan diri. Tunjukkan bahwa keluarga mendukungnya sepenuhnya, tanpa menuntut apapun.
- c. Membandingkan dengan pengalaman orang lain: Meski bertujuan untuk memberikan harapan, membandingkan situasi wanita dengan orang lain bisa menjadi bumerang. Hindari pernyataan seperti *"Teman kita juga pernah mengalami ini, tapi dia sekarang sudah punya anak."* atau *"Ada banyak pasangan yang melalui hal ini, kamu tidak sendirian."* Kalimat ini dapat membuat wanita merasa bahwa emosinya dianggap sepele. Fokuslah pada pengalaman yang sedang dialami.
- d. Menghindari percakapan: Dalam beberapa kasus, keluarga mungkin merasa tidak tahu apa yang harus dikatakan, sehingga memilih untuk menghindari percakapan sama sekali. Namun, sikap diam ini dapat disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Sebaliknya, cobalah untuk mengungkapkan perasaan pasangan/ keluarga, meskipun sederhana, seperti *"Aku mungkin tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat peduli."* Komunikasi, meskipun kecil, dapat menunjukkan dukungan yang besar.

2. Pentingnya Mendengarkan Tanpa Menghakimi

Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh wanita yang mengalami keguguran adalah rasa takut untuk berbicara tentang perasaannya karena khawatir akan dihakimi atau disalahkan. Oleh karena itu, mendengarkan tanpa menghakimi menjadi kunci penting dalam mendukung pemulihan mereka (Lee, Ma, Davies, & Kammers, 2023).

- a. Menjadi pendengar aktif: Anggota keluarga perlu memberikan perhatian penuh ketika wanita tersebut berbicara. Tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi juga memahami emosi di balik ucapan tersebut. Kontak mata, anggukan kecil, atau ungkapan seperti *"Aku mengerti"* dapat menunjukkan bahwa keluarga benar-benar hadir untuk mendengarkan.
- b. Tidak memberikan penilaian: Hindari memberikan komentar yang terkesan menyalahkan atau mengkritik, seperti *"Seharusnya kamu lebih berhati-hati"* atau *"Mungkin ini salahmu."* Komentar semacam ini dapat memperburuk perasaan bersalah yang sudah dirasakan. Sebaliknya, biarkan wanita tersebut berbicara tanpa interupsi atau kritik.

- c. Memberikan ruang untuk berekspresi: Biarkan wanita tersebut mengungkapkan perasaannya tanpa interupsi. Kadang-kadang, mereka hanya butuh tempat untuk mencurahkan isi hati tanpa mencari solusi. Ketika keluarga memberikan ruang yang aman untuk berbicara, wanita tersebut akan merasa lebih dihargai dan dipahami.
- d. Menghindari saran yang tidak diminta: Meskipun niatnya baik, saran yang tidak diminta sering kali tidak membantu dan dapat membuat wanita merasa bahwa perasaannya tidak dihargai. Fokuslah untuk mendengarkan dan mendukung, kecuali jika mereka secara khusus meminta pendapat atau saran.

3. Mengatasi Konflik Keluarga yang Mungkin Muncul

Proses pemulihan pasca keguguran tidak selalu berjalan mulus, dan konflik dalam keluarga mungkin saja muncul. Konflik ini bisa disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap situasi, tekanan emosional yang dirasakan oleh semua pihak, atau ketidakseimbangan dalam memberikan perhatian. Misalnya, beberapa anggota keluarga mungkin merasa tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk membantu, sementara yang lain mungkin merasa bahwa upaya mereka tidak cukup dihargai. Untuk mengatasi konflik, keluarga dapat melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengelola emosi dengan bijak: Semua pihak perlu belajar mengendalikan emosi, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Jangan biarkan emosi sesaat memperburuk hubungan antar anggota keluarga. Latihan seperti teknik pernapasan atau meditasi dapat membantu mengelola stres.
- b. Membangun komunikasi yang terbuka: Komunikasi yang jujur dan terbuka dapat membantu menyelesaikan kesalahpahaman. Diskusikan masalah dengan kepala dingin dan fokus pada solusi, bukan pada saling menyalahkan. Misalnya, keluarga dapat merencanakan waktu khusus untuk berdiskusi tanpa gangguan eksternal.
- c. Menghargai perbedaan pandangan: Setiap anggota keluarga mungkin memiliki cara pandang yang berbeda terhadap situasi ini. Penting untuk saling menghormati perbedaan tersebut dan mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak.
- d. Mencari bantuan profesional: Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara mandiri, mempertimbangkan konseling keluarga atau terapi dapat menjadi alternatif untuk memperbaiki dinamika keluarga. Seorang konselor atau psikolog dapat membantu menjembatani komunikasi yang terhambat dan memberikan panduan untuk menghadapi situasi sulit ini.
- e. Meningkatkan Spiritualitas: Bagi sebagian pasangan, spiritualitas dapat menjadi sumber kekuatan selama masa pemulihan. Berdoa atau melakukan

aktivitas keagamaan bersama dapat memberikan ketenangan dan harapan. Cara meningkatkan spiritualitas dapat dengan menghadiri kegiatan keagamaan, bergabung dalam komunitas keagamaan yang mendukung, merenung atau meditasi, serta berbagi rasa syukur dengan fokus pada hal-hal baik yang masih dimiliki.

4. Membantu Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Nyaman

Lingkungan yang aman dan nyaman adalah elemen penting dalam mendukung proses pemulihan wanita pasca keguguran. Keluarga dapat menciptakan suasana yang kondusif dengan cara berikut:

- a. Menjaga privasi dan kenyamanan: Hindari membahas pengalaman keguguran secara terbuka dengan orang luar tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan. Jaga privasi mereka agar merasa aman dan dihormati. Privasi juga membantu mengurangi tekanan dari komentar atau pertanyaan yang tidak diinginkan.
- b. Mengurangi tekanan sosial: Berikan waktu dan ruang bagi wanita tersebut untuk beristirahat tanpa harus menghadapi tuntutan sosial, seperti menghadiri acara keluarga atau menjawab pertanyaan yang menyakitkan dari orang lain. Tekanan sosial sering kali dapat memperburuk rasa cemas atau stres.
- c. Menciptakan suasana positif di rumah: Pastikan suasana di rumah mendukung kenyamanan dan ketenangan. Misalnya, mendekorasi ulang ruang dengan warna-warna yang menenangkan atau menyediakan tempat khusus untuk relaksasi dapat membantu meningkatkan suasana hati.

5. Dukungan Psikologis dan Profesional

Dukungan psikologis dan profesional sangat penting bagi individu yang mengalami keguguran untuk dapat mengatasi perasaan mereka dan kembali pulih. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana dukungan psikologis dan profesional dapat diberikan, mulai dari akses ke konselor atau psikolog, hingga peran keluarga dalam mendorong pencarian bantuan profesional.

- a. Pentingnya Mendukung Akses ke Konselor atau Psikolog
 - 1) Setelah mengalami keguguran, banyak wanita merasa kesulitan untuk mengatasi perasaan mereka. Perasaan kehilangan, kesedihan, dan kecemasan sering kali muncul setelah keguguran, dan jika tidak ditangani dengan baik, perasaan ini bisa berkembang menjadi gangguan mental seperti depresi atau kecemasan kronis. Oleh karena itu, mendapatkan dukungan dari seorang konselor atau psikolog sangatlah penting. Keluarga dapat menawarkan bantuan untuk mengantar wanita menemui konselor atau psikolog. Konselor atau psikolog memiliki keterampilan dan

pengalaman untuk membantu individu memahami dan mengelola perasaan mereka setelah keguguran. Mereka dapat memberikan ruang yang aman dan bebas dari penilaian bagi individu untuk mengungkapkan perasaan mereka, serta membantu mereka menerima kenyataan dan memproses perasaan mereka dengan cara yang sehat. Melalui sesi konseling, individu dapat belajar untuk mengatasi rasa kehilangan dan kecemasan yang muncul, serta mengembangkan mekanisme koping yang lebih baik dalam menghadapi perasaan tersebut.

- 2) Selain itu, perasaan yang muncul pasca keguguran sering kali sangat kompleks. Rasa bersalah adalah salah satu perasaan yang kerap muncul, di mana seseorang mungkin merasa bahwa keguguran tersebut adalah akibat dari kesalahan yang dilakukan, meskipun sebenarnya itu adalah hal yang tidak dapat dikendalikan. Seorang psikolog dapat membantu individu untuk mengatasi perasaan bersalah ini dan memberikan pemahaman bahwa keguguran adalah kejadian yang terjadi pada banyak wanita dan tidak menunjukkan kegagalan sebagai seorang ibu. Seorang konselor atau psikolog juga dapat membantu wanita untuk memahami bahwa perasaan mereka adalah reaksi normal terhadap peristiwa traumatis. Dukungan dari seorang profesional membantu mengurangi perasaan terisolasi dan memberi keyakinan bahwa perasaan mereka dapat dipahami dan dikelola dengan cara yang positif.

b. Bagaimana Mendampingi Saat Proses Terapi

Proses terapi pasca keguguran bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu singkat. Pemulihan emosional adalah perjalanan yang memerlukan waktu dan dukungan yang konsisten. Selain dukungan dari seorang psikolog atau konselor, pasangan, keluarga, atau teman sangatlah penting dalam membantu individu melewati proses terapi ini. Mendampingi seseorang yang menjalani terapi pasca keguguran berarti memberikan dukungan emosional yang penuh perhatian. Salah satu aspek penting dalam mendampingi adalah menunjukkan empati. Hal ini berarti memahami dan merasakan perasaan yang sedang dialami oleh individu tersebut tanpa menghakimi atau mencoba untuk memperbaiki situasi dengan cepat. Dalam banyak kasus, wanita yang mengalami keguguran merasa kesulitan untuk berbicara tentang perasaan mereka, atau bahkan merasa cemas berbagi perasaan dengan orang lain karena takut tidak dipahami. Di sinilah peran keluarga sebagai pendamping sangat penting untuk memberi ruang bagi wanita untuk berbicara kapan pun mereka siap, serta memberikan dukungan dengan cara yang penuh pengertian.

Selain itu, keluarga juga perlu mendukung keberlanjutan terapi itu sendiri. Terkadang, wanita merasa ragu untuk melanjutkan sesi terapi karena merasa tidak ada perubahan atau merasa tidak nyaman untuk menghadapi perasaan yang belum terselesaikan. Pada saat seperti ini, keluarga selaku pendamping perlu memberikan dorongan untuk terus melanjutkan terapi, mengingatkan pentingnya proses ini bagi pemulihan mereka. Tugas pendamping bukanlah untuk memberikan solusi atau saran medis, tetapi untuk memastikan bahwa wanita merasa didukung, dipahami, dan merasa aman untuk menghadapi perasaan mereka selama proses terapi.

c. Menjadi Pendamping Saat Pemeriksaan Medis Lanjutan

Setelah keguguran, wanita sering kali perlu menjalani pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan bahwa tubuh mereka pulih dengan baik dan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Pemeriksaan medis lanjutan ini bisa melibatkan berbagai prosedur, seperti tes darah, pemeriksaan ultrasound, atau pemeriksaan lainnya yang bertujuan untuk memantau pemulihan fisik Kementerian Kesehatan RI (2020). Namun, meskipun pemeriksaan medis lanjutan adalah bagian dari pemulihan fisik, proses ini sering kali dapat menimbulkan kecemasan yang mendalam. Wanita yang baru saja mengalami keguguran mungkin merasa cemas tentang kemungkinan adanya komplikasi atau kekhawatiran bahwa mereka mungkin tidak dapat hamil lagi di masa depan. Selain itu, kekhawatiran tentang apakah tubuh mereka telah benar-benar pulih atau tidak sering kali mengganggu ketenangan pikiran mereka. Keluarga sebagai pendamping, penting untuk hadir di sisi wanita selama pemeriksaan medis lanjutan. Kehadiran keluarga yang setia mendampingi dapat memberikan rasa tenang dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan selama waktu yang penuh kecemasan ini. Terkadang, hanya dengan mendampingi, menawarkan kata-kata penghiburan, atau hanya duduk di samping mereka dapat membuat perbedaan besar. Keluarga juga dapat membantu dengan mengajukan pertanyaan kepada tenaga medis mengenai prosedur atau hasil pemeriksaan, serta memastikan bahwa wanita tersebut memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam pemulihan. Namun, menjadi pendamping dalam pemeriksaan medis lanjutan juga berarti memberi ruang bagi wanita untuk merasa nyaman dan didengar. Jika wanita merasa cemas atau membutuhkan waktu untuk berbicara dengan tenaga medis, pendamping perlu memberikan dukungan dan kebebasan untuk melakukan itu. Pada akhirnya, tujuan pendampingan adalah untuk memastikan bahwa wanita merasa diperhatikan dan dipahami, baik dari sisi emosional maupun fisik.

D. Dukungan Praktis yang Dapat Diberikan Keluarga

Keluarga dapat memberikan dukungan dalam bentuk-bentuk praktis yang sangat berarti dalam proses pemulihan. Berbagai cara praktis yang dapat dilakukan keluarga untuk mendukung wanita pasca keguguran adalah dengan fokus pada memenuhi kebutuhan fisik, memberikan bantuan sehari-hari, serta membantu mengelola stres dan memberikan waktu yang cukup untuk pemulihan.

1. Membantu Wanita Memenuhi Kebutuhan Fisik Pasca Keguguran

Pasca keguguran, tubuh seorang wanita membutuhkan waktu untuk pulih (National Health Service, 2022a). Proses keguguran sering kali melibatkan kehilangan darah yang signifikan, perubahan hormon yang mendadak, serta kemungkinan adanya rasa nyeri atau ketidaknyamanan fisik. Selain itu, pemeriksaan medis lanjutan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tubuh mereka telah pulih sepenuhnya dan tidak ada komplikasi seperti infeksi atau masalah kesehatan lainnya. Dalam kondisi ini, bantuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik wanita sangatlah penting.

a. Mendukung Pemulihan Pasca Operasi atau Prosedur Medis

Jika keguguran terjadi dalam kondisi yang memerlukan prosedur medis seperti kuretase, tubuh wanita akan membutuhkan waktu untuk pulih dari operasi tersebut Kementerian Kesehatan RI (2020). Dalam situasi ini, keluarga dapat membantu memastikan bahwa wanita tersebut mendapatkan perawatan pasca operasi yang tepat. Hal ini meliputi membantu mengingatkan jadwal obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter, memastikan bahwa ia mengonsumsi makanan yang cukup bergizi untuk mempercepat penyembuhan, serta mendorong istirahat yang cukup.

b. Memberikan Asupan Nutrisi yang Tepat

Pemulihan fisik membutuhkan asupan nutrisi yang baik. Keluarga harus memastikan bahwa wanita pasca keguguran harus mendapatkan cukup mineral dan vitamin setiap hari dengan mengonsumsi makanan yang bervariasi yang mencakup susu, dan buah-buahan segar (Banerjee, 2022). Kalsium dalam susu merupakan bentuk mineral yang paling mudah dicerna. Pasca keguguran, seorang wanita juga kehilangan banyak darah, sehingga membutuhkan makanan yang kaya akan zat besi untuk membantu proses regenerasi darah. Sayuran hijau, daging merah, kacang-kacangan, dan makanan lainnya yang kaya zat besi sangat bermanfaat. Selain itu, makanan yang kaya akan vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi secara lebih baik (Koletzko, et al 2018). Keluarga dapat membantu dengan menyiapkan

makanan bergizi ini secara teratur dan memastikan bahwa wanita tersebut tidak melewatkan waktu makan.

c. Membantu Mengelola Nyeri Fisik

Keguguran sering kali meninggalkan rasa nyeri fisik, baik dalam bentuk kram atau ketidaknyamanan lainnya. Keluarga dapat membantu dengan menyediakan perawatan sederhana, seperti menyiapkan air hangat untuk mandi, memberikan kompres hangat untuk meredakan nyeri, atau hanya menyediakan tempat yang nyaman bagi wanita untuk beristirahat. Bantuan ini tampak sederhana, tetapi sangat berarti dalam membantu proses pemulihan fisik.

2. Memberikan Bantuan Sehari-hari, seperti Mengurus Rumah Tangga atau Anak

Selain pemulihan fisik, seorang wanita yang baru saja mengalami keguguran sering kali merasa kewalahan dengan tugas sehari-hari, terutama jika ia juga memiliki tanggung jawab lain, seperti mengurus rumah tangga atau anak-anak. Dalam situasi ini, bantuan dari keluarga dalam mengelola tugas sehari-hari sangatlah penting.

a. Mengurus Rumah Tangga

Setelah keguguran, wanita sering kali merasa lelah secara fisik dan emosional, sehingga sulit untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga seperti biasa. Keluarga dapat mengambil alih tanggung jawab ini, termasuk memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan tugas-tugas lainnya. Dengan mengambil alih tugas-tugas ini, keluarga memberikan kesempatan kepada wanita untuk fokus pada pemulihan tanpa merasa terbebani oleh tanggung jawab sehari-hari.

b. Membantu Mengurus Anak-anak

Jika wanita yang mengalami keguguran memiliki anak-anak, mengurus mereka bisa menjadi tantangan yang sangat berat dalam kondisi emosional dan fisik yang belum pulih. Keluarga dapat membantu dengan mengasuh anak-anak sementara waktu, seperti mengantar mereka ke sekolah, membantu mereka mengerjakan tugas sekolah, atau bahkan hanya bermain dengan mereka untuk mengalihkan perhatian. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban fisik, tetapi juga memberikan ruang bagi wanita untuk beristirahat dan fokus pada pemulihannya.

c. Mengelola Tugas-Tugas Harian

Keluarga juga dapat membantu dengan hal-hal kecil yang sering kali terabaikan tetapi sebenarnya sangat berarti, seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari, mengambil obat-obatan di apotek, atau bahkan memastikan

bahwa tagihan-tagihan penting telah dibayar tepat waktu. Tugas-tugas kecil ini mungkin terasa sepele, tetapi dalam kondisi pasca keguguran, mereka dapat menjadi sumber stres.

d. **Memberikan Ruang untuk Istirahat**

Terkadang, bantuan yang paling berarti adalah memberikan ruang kepada wanita untuk beristirahat tanpa merasa bersalah atau khawatir tentang tanggung jawab sehari-hari. Dengan mengambil alih tugas-tugas yang biasanya menjadi tanggung jawabnya, keluarga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemulihan.

E. Langkah-langkah Pemulihan Jangka Panjang

Pemulihan jangka panjang perlu dilakukan dan disepakati oleh wanita yang mengalami keguguran dengan pasangannya. Pemulihan jangka panjang ini juga termasuk menyusun harapan serta rencana kehamilan yang akan datang.

1. Menyusun Harapan dan Rencana untuk Masa Depan

Pasca keguguran, banyak pasangan merasa kehilangan arah atau harapan terhadap rencana hidup mereka, terutama yang berkaitan dengan memiliki anak. Untuk itu, menyusun harapan dan rencana masa depan secara realistis menjadi langkah awal yang penting. Cara mengelola harapan:

- a. **Evaluasi Kondisi Kesehatan:** Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter tentang kondisi kesehatan fisik dan kemungkinan untuk hamil kembali.
- b. **Diskusikan Rencana Bersama Pasangan:** Libatkan pasangan dalam menyusun rencana masa depan agar keduanya merasa terlibat dan memiliki visi yang sama.
- c. **Fokus pada Keseimbangan Hidup:** Jangan hanya fokus pada satu tujuan, seperti memiliki anak. Luangkan waktu untuk mengejar hal-hal yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan seperti karier, hobi, atau hubungan sosial.
- d. **Tetapkan Tujuan Kecil:** Jangan terburu-buru menyusun rencana besar. Mulailah dengan langkah kecil seperti memastikan kesehatan fisik dan mental terlebih dahulu.
- e. **Terbuka terhadap Alternatif:** Jika menghadapi kendala untuk hamil kembali, buka diri terhadap opsi lain seperti adopsi atau program bayi tabung, jika memungkinkan dan sesuai dengan keinginan.

2. Kapan Mulai Mencoba Kembali untuk Hamil (Jika Diinginkan)

Waktu terbaik untuk mencoba hamil kembali berbeda-beda untuk setiap wanita, tetapi beberapa layanan kesehatan menganjurkan wanita untuk

menunggu setidaknya beberapa bulan untuk memperkuat peluang kehamilan yang sehat. Jika tubuh wanita tidak siap untuk menghadapi kehamilan, ia akan menghadapi risiko mengalami keguguran berulang. Butuh waktu bagi rahim untuk pulih dan bagi lapisan endometrium untuk menjadi kuat dan sehat lagi. Beberapa rekomendasi waktu yang aman untuk hamil yaitu setelah dua atau tiga periode menstruasi normal (American Pregnancy Association, 2024b). Beberapa hal untuk mendukung kesiapan hamil kembali adalah menyiapkan kondisi fisik. Kondisi fisik sangat penting untuk menyiapkan kehamilan yang sehat. Pemeriksaan medis termasuk pemeriksaan rahim, hormonal, dan tambahan lainnya mungkin akan dilakukan untuk mengurangi resiko keguguran berulang. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendiskusikan dengan tim layanan kesehatan terkait pertimbangan untuk mengonsumsi suplemen dan vitamin seperti asam folat, serta pola hidup sehat termasuk olahraga ringan dan pola makan seimbang. Persiapan lainnya adalah menentukan waktu yang tepat. Hal ini mencakup kondisi mental dan emosional cukup stabil sebelum memutuskan untuk mencoba hamil kembali. Hal yang wajar jika ada rasa takut atau cemas saat mencoba hamil kembali. Untuk mengatasi perasaan ini wanita dapat berlatih cara menenangkan diri dengan teknik rileksasi dan meditasi. Wanita dan pasangan juga harus berkomunikasi dan berdiskusi mengenai kesepakatan serta kesiapan waktu yang tepat untuk mencoba kehamilan kembali yang dimulai dari memahami siklus ovulasi, memonitor tanda-tanda kesuburan, serta perencanaan kapan pembuahan dilakukan. Penting juga untuk mempertimbangkan dukungan emosional dari petugas profesional kesehatan mental jika diperlukan, agar perjalanan kehamilan yang baru dapat dimulai dengan penuh keyakinan dan optimisme.

F. Referensi

-
- Alqassim, M. Y., Kresnye, K. C., Siek, K. A., Lee, J., & Wolters, M. K. (2022). The miscarriage circle of care: towards leveraging online spaces for social support. *BMC Women's Health*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01597-1>
- American Pregnancy Association. (2010). Miscarriage. Retrieved from https://www.cdc.gov/niosh/docket/archive/pdfs/NIOSH-105-A/0105-A-011310-AmericanPregnancy_Ref.pdf
- American Pregnancy Association. (2024a). After a Miscarriage: Surviving Emotionally. Retrieved from <https://americanpregnancy.org/getting-pregnant/pregnancy-loss/miscarriage-surviving-emotionally/>
- American Pregnancy Association. (2024b). Pregnancy After Miscarriage. Retrieved

from <https://americanpregnancy.org/getting-pregnant/pregnancy-loss/pregnancy-after-miscarriage/>

- Banerjee, S. (2022). Role of the Proper Nutrition for Indian Women with Recurrent Pregnancy Loss (RPL). *Journal of Prevention, Diagnosis and Management of Human Diseases*, (31), 1–9. <https://doi.org/10.55529/jpdmhd.31.1.9>
- Bellhouse, C., Temple-Smith, M. J., & Bilardi, J. E. (2018). "It's just one of those things people don't seem to talk about." women's experiences of social support following miscarriage: A qualitative study 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services. *BMC Women's Health*, 18(1), 1–9.
- Gold, K. J., Sen, A., & Hayward, R. A. (2010). Marriage and Cohabitation Outcomes After Pregnancy Loss. *Pediatrics*, 125(5), e1202–e1207. <https://doi.org/doi.org/10.1542/peds.2009-3081>
- Hopkinsmedicine. (2024). Miscarriage. Retrieved from <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/miscarriage>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman nasional asuhan pasca keguguran yang komprehensif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Koletzko Monika; Flothkötter, Maria; Graf, Christine; Hauner, Hans; Hellmers, Claudia; Kersting, Mathilde; Krawinkel, Michael; Przyrembel, Hildegard; Röbl-Mathieu, Marianne; Schiffner, Ulrich; Vetter, Klaus; Weißenborn, Anke; Wöckel, Achim, B. C. (2018). Diet and Lifestyle Before and During Pregnancy – Practical Recommendations of the Germany-wide Healthy Start – Young Family Network TT - Ernährung und Lebensstil vor und während der Schwangerschaft – Handlungsempfehlungen des bundesweiten Netzwerks Gesun. *Geburtshilfe Frauenheilkd*, 78(12), 1262–1282. <https://doi.org/10.1055/a-0713-1058>
- Miscarriage Association. (2024). Supporting Someone Through Pregnancy Loss. Retrieved from <https://www.miscarriageassociation.org.uk/your-feelings/supporting-someone-through-pregnancy-loss/>
- Miscarriageaustralia. (2024). Types of miscarriage. Retrieved from <https://miscarriageaustralia.com.au/understanding-miscarriage/types-of-miscarriage/>
- National Health Service. (2022a). Afterwards: Miscarriage. Retrieved from <https://www.nhs.uk/conditions/miscarriage/afterwards/#:~:text=It's common to feel tired,who have had successful pregnancies.>
- National Health Service. (2022b). Causes Miscarriage. Retrieved from <https://www.nhs.uk/conditions/miscarriage/causes/>
- Quenby, S., Gallos, I. D., Dhillon-Smith, R. K., Podsek, M., Stephenson, M. D., Fisher, J., ... Coomarasamy, A. (2021). Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. *The*

Lancet, 397(10285), 1658–1667. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00682-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00682-6)

Rupp, Michelle Mouri., Heather Hall., T. J. (2024). Threatened Miscarriage. *StatPearls [Internet]*. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430747/>

Swanson K. M. (1999). Effects of caring, measurement, and time on miscarriage impact and women's well-being. *Nursing Research*, 48(6), 288–298. <https://doi.org/doi.org/10.1097/00006199-199911000-00004>

The American College of Obstetricians and Gynecologists. (2024). Early Pregnancy Loss. Retrieved from <https://www.acog.org/womens-health/faqs/early-pregnancy-loss>

Yoon, M. S., Jeon, Y. Bin, & Lee, S. B. (2023). Grief, Partner Support, Posttraumatic Growth among Women with Pregnancy Loss in Korea. *Journal of Loss and Trauma*, 28(3), 206–216. <https://doi.org/10.1080/15325024.2022.2106682>

PROFIL PENULIS



Nurmila, SST, M.Kes Lahir di Lhoksukon, 23 Agustus 1975. adalah sebagai Dosen Tetap di Poltekkes Kemenkes Aceh Prodi D-III Kebidanan Aceh Utara. Penulis menyelesaikan Pendidikan D-IV Perawat Pendidik dengan Jurusan Keperawatan Anak Tahun 2001 di Universitas Sumatera Utara, kemudian mengikuti Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Kesehatan Reproduksi pada Universitas Sumatera Utara Lulus tahun 2014. Saat ini penulis Aktif sebagai Dosen Pengajar dengan Jabatan Asisten Ahli dan melakukan kegiatan Penelitian , Pengabdian serta menulis Karya Ilmiah yang dipublikasi untuk skala Nasional. Rekam Jejak Penulis dapat dilihat di Profil Google Scholar. Penulis saat ini mengajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi ,Balita dan Anak Prasekolah. Kebutuhan Dasar Manusia dan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Email Penulis : milaabubakar75@gmail.com



Eni Folendra Rosa, SKM., MPH Lahir di Baturaja, 04 November 1966. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis diawali pada Akademi Keperawatan Depkes Palembang, Pendidikan Bidan Program B Pajajaran Bandung dan Diploma 3 Kebidanan. Jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan Ibu Anak dan Kesehatan Reproduksi pada Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1990 sebagai Guru SPK Depkes Baturaja dan sejak tahun 2002 sebagai Dosen Poltekkes Kemenkes Palembang pada Prodi Keperawatan Baturaja. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak, Komunikasi Keperawatan dan Management Patient Safety. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi pada jurnal nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: enifrosa@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Anita Rahmawati, M.Kep Lahir di Kediri, 19 Februari 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya Malang tahun 2003-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di STIKes Patria Husada Blitar dan mengampu mata kuliah keperawatan maternitas dan keperawatan anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pembicara seminar baik lokal maupun nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anitarahmawati2017@gmail.com



Ns. Siti Munawaroh, M.Kep., Lahir di Semarang, 24 Desember 1982. Anak terakhir dari dua bersaudara. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota Semarang, penulis bekerja dulu 2 tahun baru menempuh pendidikan S1 Keperawatan di STIKES Kendal lulus tahun 2008. Selanjutnya penulis mendapat gelar Magister Keperawatan (M.Kep) di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2018. Pengalaman mengajar dari tahun 2009 sampai sekarang di Apker Muhammadiyah Kendal yang sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Selain sebagai pengajar penulis juga sebagai editor jurnal institusi Jurnal Surya Muda yang sudah terakreditasi sinta 5. Semoga sedikit ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh penulis melalui buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: siti.muna31@yahoo.co.id

Motto: "Selalu bersyukur dengan semua yang kita peroleh dalam hidup karena dari sana akan menemukan kebahagiaan yang sejati"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Manajemen Kesehatan Reproduksi menghadirkan kumpulan kajian yang mendalam mengenai peran keluarga dalam berbagai tahapan penting kehidupan reproduksi. Buku ini menggambarkan bagaimana keluarga bukan hanya sebagai lingkungan sosial pertama, tetapi juga sebagai sistem pendukung utama dalam menjaga kesehatan reproduksi anggota-anggotanya, mulai dari masa remaja, proses menyusui, pasca melahirkan, hingga pemulihan setelah keguguran. Setiap bab dalam buku ini ditulis oleh para ahli di bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat yang telah berpengalaman, memberikan perspektif ilmiah sekaligus praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan keluarga dan komunitas.

Bab pertama hingga bab ketiga membahas secara berurutan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, dukungan keluarga terhadap ibu menyusui, serta peran keluarga dalam merawat perempuan selama masa puerperium. Pembahasan ini tidak hanya menyentuh aspek medis dan psikologis, tetapi juga menekankan pentingnya pola komunikasi yang sehat dan edukatif dalam keluarga. Selanjutnya, bab keempat menjelaskan tentang peran keluarga dalam mendampingi remaja menghadapi perubahan fisik dan emosional mereka, sementara bab kelima secara empatik menyoroti dukungan keluarga dalam proses pemulihan pasca keguguran, yang kerap kali menjadi pengalaman emosional yang berat bagi seorang perempuan dan pasangannya.

Secara keseluruhan, buku ini menjadi panduan komprehensif bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, serta keluarga Indonesia dalam memahami dan menjalankan peran mereka dalam mendukung kesehatan reproduksi. Buku ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi kesehatan reproduksi berbasis keluarga, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong terciptanya lingkungan rumah yang lebih sehat dan suportif bagi semua anggota keluarga, khususnya perempuan dan remaja. Sebagai bunga rampai, buku ini menyajikan kombinasi teori, data empiris, dan rekomendasi praktis yang saling melengkapi dan memperkaya pemahaman pembaca.

Buku Bunga Rampai Keperawatan Keluarga dalam Manajemen Kesehatan Reproduksi menghadirkan kumpulan kajian yang mendalam mengenai peran keluarga dalam berbagai tahapan penting kehidupan reproduksi. Buku ini menggambarkan bagaimana keluarga bukan hanya sebagai lingkungan sosial pertama, tetapi juga sebagai sistem pendukung utama dalam menjaga kesehatan reproduksi anggota-anggotanya, mulai dari masa remaja, proses menyusui, pasca melahirkan, hingga pemulihan setelah keguguran. Setiap bab dalam buku ini ditulis oleh para ahli di bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat yang telah berpengalaman, memberikan perspektif ilmiah sekaligus praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan keluarga dan komunitas.

Bab pertama hingga bab ketiga membahas secara berurutan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, dukungan keluarga terhadap ibu menyusui, serta peran keluarga dalam merawat perempuan selama masa puerperium. Pembahasan ini tidak hanya menyentuh aspek medis dan psikologis, tetapi juga menekankan pentingnya pola komunikasi yang sehat dan edukatif dalam keluarga. Selanjutnya, bab keempat menjelaskan tentang peran keluarga dalam mendampingi remaja menghadapi perubahan fisik dan emosional mereka, sementara bab kelima secara empatik menyoroti dukungan keluarga dalam proses pemulihan pasca keguguran, yang kerap kali menjadi pengalaman emosional yang berat bagi seorang perempuan dan pasangannya.

Secara keseluruhan, buku ini menjadi panduan komprehensif bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, serta keluarga Indonesia dalam memahami dan menjalankan peran mereka dalam mendukung kesehatan reproduksi. Buku ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi kesehatan reproduksi berbasis keluarga, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong terciptanya lingkungan rumah yang lebih sehat dan suportif bagi semua anggota keluarga, khususnya perempuan dan remaja. Sebagai bunga rampai, buku ini menyajikan kombinasi teori, data empiris, dan rekomendasi praktis yang saling melengkapi dan memperkaya pemahaman pembaca.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-29-9



9

786347

219299